

Monograf

PENGARUH EVALUASI BERKALA KINERJA PERAWAT TERHADAP MUTU PELAYANAN KEPERAWATAN

Ns. Nur Samti Rumadaul, S.Kep

Dr. Blacius Dedi, SKM., M.Kep

Dr. Ns. Tri Ismu, SKM, S.Kep, M.Kes, M.Kep



**BUKU MONOGRAF:
PENGARUH EVALUASI BERKALA
KINERJA PERAWAT TERHADAP MUTU
PELAYANAN KEPERAWATAN**

Penulis:

Ns. Nur Samti Rumadaul, S.Kep

Dr. Blacius Dedi, SKM., M.Kep

Dr. Ns. Tri Ismu, SKM, S.Kep, M.Kes, M.Kep



Buku Monograf: Pengaruh Evaluasi Berkala Kinerja Perawat Terhadap Mutu Pelayanan Keperawatan

Penulis: Ns. Nur Samti Rumadaul, S.Kep.
Dr. Blacius Dedi, SKM., M.Kep.
Dr. Ns. Tri Ismu, SKM., S.Kep, M.Kes., M.Kep.

Desain Sampul : Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak : Helmi Syaukani, S.Pd.

ISBN : 978-634-7294-93-7
Terbit : September, 2025

**Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
All Right Reserved
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin
tertulis dari Penerbit.**



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta

Instagram: @bimbel.optimal
Tiktok: @maskokooo
www.optimaluntuknegeri.com
Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025



PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku monograf berjudul *“Pengaruh Evaluasi Berkala Kinerja Perawat terhadap Mutu Pelayanan Keperawatan”* ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan buku ini bertujuan untuk mendokumentasikan dan mengkaji secara mendalam bagaimana proses evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala dapat memengaruhi mutu pelayanan keperawatan, khususnya di lingkungan RSUD Kabupaten Raja Ampat. Pelayanan keperawatan sebagai bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan memiliki peran penting dalam menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kepuasan pasien. Penguatan sistem evaluasi kinerja menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang berkelanjutan.

Buku ini disusun dengan harapan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai pentingnya pelaksanaan evaluasi kinerja secara berkala bagi tenaga keperawatan melalui pendekatan ilmiah, data, dan refleksi dari praktik nyata di lapangan. Buku ini mengungkap keterkaitan antara peningkatan kinerja perawat dengan mutu pelayanan keperawatan. Kami berharap buku ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi yang bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi para perawat, pimpinan fasilitas layanan kesehatan, peneliti, dan pemangku kebijakan yang memiliki perhatian terhadap pengembangan mutu pelayanan keperawatan.

Ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan buku ini, terutama kepada para perawat di RSUD Kabupaten Raja Ampat

yang telah berpartisipasi dan berbagi pengalaman, serta kepada tim penulis dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan mutu pelayanan keperawatan di Indonesia. Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan, untuk itu kami terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan di masa yang akan datang.



DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB 1 PENDAHULUAN	1
--------------------------------	----------

BAB 2 KONSEP MUTU PELAYANAN KEPERAWATAN.....	6
---	----------

A. Pengertian Mutu Pelayanan Keperawatan.....	6
B. Dimensi Mutu Pelayanan Keperawatan.....	7
C. Indikator Mutu Pelayanan Keperawatan.....	13

BAB 3 KONSEP KINERJA PERAWAT	18
---	-----------

A. Konsep Dasar Kinerja	18
B. Kinerja Perawat.....	20
C. Indikator Kinerja Perawat.....	26
D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Perawat.....	30
E. Pengukuran Kinerja Perawat	35
F. Upaya Meningkatkan Kinerja Perawat.....	37

BAB 4 PENGENDALIAN PELAYANAN KEPERAWATAN	42
---	-----------

A. Pengertian Pengendalian Pelayanan Keperawatan	42
B. Manfaat Pengendalian Pelayanan Keperawatan.....	44
C. Prinsip Pengendalian Pelayanan Keperawatan.....	46
D. Langkah-Langkah Pengendalian Pelayanan Keperawatan	48

BAB 5 PENGARUH EVALUASI KINERJA PERAWAT	
TERHADAP MUTU PELAYANAN KEPERAWATAN	51
A. Evaluasi Kinerja Perawat.....	51
B. Periode Evaluasi Kinerja Perawat.....	52
C. Pengaruh Evaluasi Evaluasi Berkala Kinerja Perawat	
Terhadap Mutu Pelayanan Keperawatan.....	59
 BAB 6 PENUTUP	 63
 DAFTAR PUSTAKA.....	 67
PROFIL PENULIS	72

BAB 1

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi di era modern yang ditandai globalisasi informasi dalam berbagai aspek kehidupan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ekspektasi terhadap pelayanan kesehatan juga mengalami pergeseran yang signifikan. Pasien kini tidak lagi pasif dalam menerima layanan, tetapi aktif dan selektif dalam memilih institusi kesehatan, terutama rumah sakit, berdasarkan pada kualitas pelayanan yang diberikan. Kualitas pelayanan menjadi indikator utama yang memengaruhi kepercayaan dan loyalitas pasien terhadap rumah sakit, sehingga rumah sakit dituntut untuk memiliki komitmen yang kuat dalam memberikan pelayanan berkualitas melalui penerapan kebijakan dan prosedur berbasis bukti (Pitkanen & Linnosmaa, 2021).

Pelayanan keperawatan menjadi salah satu aspek yang sangat menentukan mutu layanan kesehatan secara keseluruhan. Perawat merupakan tenaga kesehatan dengan jumlah terbanyak dibandingkan tenaga kesehatan lainnya, menjadikan mereka sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan langsung kepada pasien. Pelayanan keperawatan sendiri adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang tidak hanya berorientasi pada tindakan klinis, tetapi juga pada interaksi interpersonal antara perawat, pasien, dan keluarga

pasien. Interaksi ini berlangsung terus menerus selama 24 jam, menjadikan peran perawat sangat krusial dalam menentukan pengalaman pasien selama menjalani perawatan di rumah sakit (Baumann & Crea-Arsenio, 2023).

Kinerja perawat yang optimal tidak hanya menentukan keberhasilan intervensi medis, tetapi juga berpengaruh besar terhadap mutu pelayanan keperawatan dan persepsi kualitas pelayanan rumah sakit secara keseluruhan. Pasien yang datang ke rumah sakit tidak hanya membawa keluhan fisik, tetapi juga masalah psikologis dan emosional seperti kecemasan, ketakutan, dan kebingungan. Kepekaan perawat terhadap kondisi psikososial pasien sangat dibutuhkan, yang tercermin dalam perilaku caring mereka (Mrayyan et al., 2023; Stavropoulou et al., 2022).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perilaku caring perawat masih belum optimal. Studi oleh Mula & Estrada tahun 2020 mengungkapkan bahwa perilaku caring perawat masih rendah di berbagai unit pelayanan. Penelitian oleh Oluma & Abadiga tahun 2020 menunjukkan bahwa 10–30% perawat menilai kualitas perawatan di ruang rawat mereka sebagai “cukup” bahkan “buruk”, dan hingga 50% menyatakan adanya penurunan kualitas pelayanan. Hal serupa dimukakan pada hasil penelitian (Ahmed et al., 2022) menemukan bahwa hanya 49% perawat yang menunjukkan perilaku caring dalam kategori baik.

Penilaian mutu dalam studi tersebut didasarkan pada tiga dimensi utama dalam perilaku caring, yaitu: dimensi psikososial, fisik, dan komunikasi. Dimensi psikososial mencakup dukungan terhadap kesejahteraan emosional dan sosial pasien, dimensi fisik mencerminkan perawatan langsung seperti mobilisasi dan tindakan medis, sedangkan dimensi komunikasi menyangkut interaksi verbal dan nonverbal antara perawat dan pasien.

Pelayanan keperawatan yang bermutu tinggi mengharuskan adanya hubungan interpersonal yang baik antara perawat dan pasien, termasuk adanya empati dan peran perawat sebagai advokat pasien. Tantangan dalam pelayanan keperawatan sangat kompleks, mulai dari kurangnya peralatan, keterbatasan obat-obatan, keterbatasan jumlah staf, hingga lemahnya kerja tim. Semua hal tersebut secara langsung dapat menurunkan tingkat kepuasan pasien dan keluarga (Nyelisani et al., 2023).

Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa perilaku caring dan kemampuan komunikasi perawat sangat memengaruhi tingkat kepuasan pasien. Penelitian Afriliana et al tahun 2023 menemukan bahwa perilaku caring yang baik dan komunikasi efektif perawat berkorelasi positif dengan peningkatan kepuasan pasien secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek humanistik dalam pelayanan keperawatan tidak bisa diabaikan. Caring yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan dampak positif tidak hanya terhadap kondisi pasien, tetapi juga pada efisiensi sistem pelayanan rumah sakit (Lopes-Júnior, 2021).

Untuk menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan, rumah sakit perlu melakukan berbagai strategi penguatan, salah satunya adalah dengan melakukan evaluasi kinerja perawat secara berkala. Evaluasi ini tidak hanya menjadi alat manajemen, tetapi juga menjadi media pembinaan, pengawasan, dan pengendalian mutu layanan keperawatan (Malekzadeh, Abedi, Hasanpoor, & Ghasemi, 2021). Evaluasi kinerja yang efektif perlu didasarkan pada pendekatan yang sistematis dengan mempertimbangkan tiga komponen utama: input (sumber daya), proses (interaksi pelayanan), dan output (hasil layanan). Penilaian kinerja perawat yang mencakup pengetahuan, keterampilan, kepemimpinan, dan sikap profesional juga berperan besar dalam menjamin mutu

pelayanan yang berkelanjutan (Alloubani, Akhu-Zaheya, Abdelhafiz, & Almatari, 2019; Ghofrani et al., 2024).

Evaluasi kinerja juga memiliki peran motivasional. Ketika perawat mengetahui bahwa kinerjanya dipantau secara objektif dan adil, hal ini dapat memacu peningkatan profesionalisme dan komitmen terhadap mutu pelayanan (Alsadaan et al., 2023). Evaluasi yang dilakukan secara tidak tepat, tidak konsisten, atau tidak transparan dapat menurunkan motivasi dan kepuasan kerja perawat serta berdampak negatif terhadap pelayanan. Masalah utama yang sering dihadapi dalam implementasi evaluasi kinerja di rumah sakit adalah keterbatasan sistem evaluasi, baik dari segi frekuensi pelaksanaan, kualitas evaluator, maupun alat ukur yang digunakan. Evaluasi tahunan yang jarang dilakukan tidak cukup memberikan gambaran utuh tentang kinerja perawat secara berkelanjutan. Kurangnya umpan balik dan pembinaan juga menjadi hambatan dalam pengembangan kompetensi perawat secara sistematis (Ofei, Poku, Paarima, Barnes, & Kwashie, 2023; Ortega, Barrado-Narvi3n, & Bernu3s-Oliv3n, 2023).

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada April 2024 di RSUD Kabupaten Raja Ampat bahwa masih ditemukan keluhan pasien terkait kurangnya aspek komunikasi dan keramahan dalam interaksi perawat yang menandakan bahwa aspek perilaku caring belum sepenuhnya optimal. Evaluasi kinerja perawat di RSUD Kabupaten Raja Ampat hanya dilakukan sekali dalam setahun yang dirasa tidak cukup efektif untuk mendeteksi permasalahan pelayanan secara real-time. Jangka waktu yang terlalu lama antara evaluasi membuat proses pembinaan menjadi tidak responsif, serta menyulitkan manajemen untuk memberikan umpan balik yang konstruktif secara tepat waktu. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan pendekatan yaitu dengan menerapkan evaluasi kinerja secara

berkala misalnya setiap bulan. Evaluasi rutin ini diharapkan mampu mendeteksi penyimpangan sejak dini, memberikan umpan balik secara cepat, serta menjadi sarana pengembangan profesional yang berkelanjutan bagi perawat.



BAB 2

KONSEP MUTU PELAYANAN KEPERAWATAN

A. Pengertian Mutu Pelayanan Keperawatan

Mutu pelayanan keperawatan merupakan konsep kompleks dan multidimensional yang mencerminkan sejauh mana pelayanan keperawatan memenuhi standar profesi nasional maupun internasional. Mutu ini tidak hanya terkait dengan kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga mencakup keselamatan pasien, efektivitas intervensi, efisiensi sumber daya, dan kepuasan pasien. Mutu keperawatan adalah hasil dari upaya kolektif antara perawat pelaksana, manajemen keperawatan, dan kebijakan institusi kesehatan, meliputi tindakan preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif yang dilakukan secara profesional dan humanistik (Porter, Weberg, Mangold, & Malloch, 2019).

Mutu pelayanan keperawatan juga berarti serangkaian kegiatan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas asuhan, seperti penerapan praktik berbasis bukti, penggunaan indikator mutu, evaluasi hasil kinerja, serta penilaian kepuasan dan kebutuhan pasien. Mutu pelayanan tidak hanya berorientasi pada standar minimum, tetapi juga pada pemberian layanan yang empatik, responsif, dan proaktif.

Konsep ini menuntut setiap perawat untuk terus mengembangkan kompetensi dan berinovasi dalam memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan holistik mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual pasien (Dahlkemper, 2021).

B. Dimensi Mutu Pelayanan Keperawatan

Dimensi mutu pelayanan keperawatan mencerminkan berbagai aspek yang dinilai pasien dan profesional kesehatan dalam menilai kualitas layanan yang diberikan oleh perawat. Mutu pelayanan keperawatan terdiri dari lima dimensi utama, yaitu (Huber, 2018):

1. Daya Tanggap

Daya tanggap merupakan kemampuan perawat dalam memberikan respons yang cepat, tepat, dan empatik terhadap kebutuhan maupun harapan pasien. Dimensi ini menekankan pentingnya kecepatan bertindak sekaligus kepekaan emosional dalam merespons situasi pasien, terutama saat mereka mengalami kecemasan, kebingungan, atau ketidaktahuan terhadap prosedur medis yang dijalani. Respons yang baik menciptakan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan pasien terhadap pelayanan yang diberikan.

Daya tanggap dalam pelayanan keperawatan sangat dibutuhkan ketika pasien menghadapi prosedur yang baru pertama kali mereka alami. Ketika pasien tidak memahami ketentuan atau mekanisme pelayanan, perawat dituntut untuk memberikan penjelasan yang jelas, tidak membingungkan, dan disampaikan secara tenang serta menghargai. Komunikasi yang edukatif dan bersifat membimbing dapat membantu pasien merasa didampingi, bukan ditinggalkan, dalam proses perawatan.

Kualitas responsivitas dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti kemampuan menyampaikan informasi secara bijaksana, memberikan penjelasan yang terstruktur dan relevan, serta membina dan mengarahkan pasien secara tepat. Pendekatan persuasif yang ramah juga penting ketika pasien mengalami kesulitan dalam mengikuti prosedur atau merasa tidak nyaman. Tindakan-tindakan ini menunjukkan bahwa perawat tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga secara emosional dan kognitif dalam mendampingi pasien.

Daya tanggap bukan hanya menyangkut kecepatan merespons, tetapi juga mencerminkan kemampuan membangun komunikasi yang efektif dan menjalin hubungan yang saling memahami antara perawat dan pasien. Pelayanan yang responsif menjadi cerminan profesionalisme dan komitmen terhadap mutu pelayanan keperawatan yang bermutu dan berpusat pada pasien.

2. Jaminan

Jaminan merupakan dimensi mutu pelayanan keperawatan yang berkaitan dengan rasa aman dan kepercayaan yang dirasakan pasien terhadap layanan yang mereka terima. Jaminan ini mencakup kepastian bahwa perawatan dilakukan secara profesional, sesuai standar, serta menghasilkan pengalaman pelayanan yang memuaskan. Ketika pasien merasa yakin bahwa tindakan keperawatan dilakukan dengan benar, tepat waktu, dan mudah diakses, maka tingkat kepercayaan mereka terhadap rumah sakit atau fasilitas kesehatan akan meningkat.

Faktor-faktor yang membentuk persepsi jaminan mencakup profesionalisme tenaga keperawatan, komitmen organisasi terhadap mutu, serta perilaku etis

dan empatik dalam memberikan pelayanan. Perawat yang menunjukkan pengetahuan klinis yang kuat, bersikap sopan, dan mampu berkomunikasi secara baik akan lebih mudah menumbuhkan keyakinan pasien. Pelaksanaan pelayanan yang konsisten dengan standar operasional prosedur (SOP) menunjukkan bahwa tindakan keperawatan dilakukan secara sistematis dan aman.

Jaminan pelayanan yang baik tercermin dalam kepuasan pasien, integritas kerja perawat, dan sikap meyakinkan yang ditunjukkan oleh petugas. Jika dimensi ini diterapkan secara optimal, maka institusi kesehatan akan mampu membangun citra positif, meningkatkan loyalitas pasien, serta mencapai keberhasilan dalam mutu pelayanan secara menyeluruh. Pelayanan yang memberikan rasa aman tidak hanya memperkuat hubungan pasien dan perawat, tetapi juga mencerminkan tata kelola yang baik dalam organisasi pelayanan kesehatan.

3. Bukti Fisik

Bukti fisik adalah dimensi mutu pelayanan yang merujuk pada segala sesuatu yang dapat dilihat secara nyata oleh pasien, seperti fasilitas rumah sakit, peralatan medis, kebersihan lingkungan, dan tampilan tenaga kesehatan. Elemen-elemen ini memberikan kesan pertama yang kuat kepada pasien mengenai kualitas dan profesionalisme pelayanan yang akan mereka terima. Penampilan fisik pelayanan memainkan peran penting dalam membentuk kepercayaan pasien.

Aspek bukti fisik tidak hanya mencakup bangunan atau peralatan, tetapi juga mencerminkan kesiapan institusi dalam memberikan pelayanan berkualitas. Penampilan perawat, kebersihan ruang rawat, serta

tersedianya alat kesehatan yang berfungsi baik menjadi indikator penting yang memengaruhi persepsi pasien terhadap mutu layanan. Semakin tertata dan modern fasilitas yang tersedia, semakin tinggi pula keyakinan pasien terhadap kompetensi tenaga keperawatan.

Bukti fisik menunjukkan bagaimana sistem pelayanan dijalankan secara profesional, misalnya, penguasaan teknologi keperawatan, penggunaan alat secara efisien, dan dukungan sistem informasi pelayanan menunjukkan bahwa institusi berkomitmen pada pelayanan yang efektif dan aman. Penampilan perawat yang rapi dan sikap profesional turut memperkuat citra pelayanan yang kredibel dan berkualitas.

Dimensi bukti fisik tidak hanya menjadi pendukung visual dari mutu pelayanan, tetapi juga menjadi cerminan dari kesiapan tenaga kesehatan dan manajemen rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang optimal. Lingkungan yang nyaman, peralatan yang canggih, serta penampilan tenaga keperawatan yang profesional merupakan faktor kunci dalam membangun kepercayaan dan kepuasan pasien terhadap layanan yang diterima.

4. Empati

Empati merupakan dimensi penting dalam pelayanan keperawatan yang menunjukkan kemampuan perawat untuk memahami secara mendalam kondisi emosional, kebutuhan, dan kekhawatiran pasien maupun keluarganya. Empati bukan sekadar rasa simpati, tetapi melibatkan kepekaan emosional dan intelektual untuk merespons pasien secara manusiawi dan menyeluruh. Hal ini menjadi dasar dalam membangun hubungan saling percaya antara pasien dan tenaga kesehatan.

Pelayanan yang berlandaskan empati mampu

menciptakan interaksi yang hangat dan mendukung proses penyembuhan pasien. Ketika perawat mampu melihat situasi dari sudut pandang pasien, maka keputusan klinis maupun tindakan keperawatan akan lebih relevan dan sesuai dengan harapan pasien. Hubungan ini memperkuat komunikasi terapeutik dan meningkatkan kenyamanan serta kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diterima.

Empati juga melibatkan pemahaman terhadap keterbatasan kedua belah pihak. Perawat perlu memahami kondisi fisik dan psikologis pasien, sementara pasien dan keluarganya perlu diberikan pemahaman mengenai batasan tugas serta kapasitas tenaga kesehatan. Keseimbangan ini membantu menciptakan interaksi yang saling menghargai dan memperkuat kerja sama dalam proses perawatan.

Empati dapat tercermin melalui berbagai indikator, seperti perhatian individual kepada pasien, sikap serius dan profesional dalam melayani, serta keramahan dan kesediaan untuk mendengarkan secara aktif. Komunikasi terapeutik seperti mendengarkan dengan seksama, mengklarifikasi, atau memberikan respon yang menenangkan menjadi wujud nyata dari empati yang berkualitas. Perawat juga diharapkan dapat memberikan dukungan emosional yang tulus di tengah kondisi sulit yang dihadapi pasien.

Empati bukan hanya bagian dari etika profesional, melainkan juga kompetensi kunci yang mendukung mutu pelayanan keperawatan. Tenaga kesehatan yang memiliki empati tinggi mampu memberikan layanan yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan pasien. Hal ini berkontribusi besar terhadap

hasil perawatan, kepuasan pasien, serta citra positif institusi pelayanan kesehatan.

5. Keandalan

Keandalan merupakan salah satu pilar utama dalam mutu pelayanan keperawatan yang menuntut tenaga keperawatan untuk memberikan layanan secara konsisten, tepat, dan dapat dipercaya. Seorang perawat yang andal memiliki kompetensi profesional yang mencakup pengetahuan teoretis, keterampilan teknis, dan sikap kerja yang profesional. Konsistensi dalam pelayanan ini menjamin pasien menerima perawatan yang aman, akurat, dan sesuai standar tanpa banyak keluhan atau kesalahan.

Keandalan tidak hanya mencerminkan ketepatan teknis, tetapi juga kesiapan perawat dalam menjalankan prosedur sesuai standar operasional (SOP) dan menghadapi tantangan klinis secara efektif. Perawat yang andal mampu merespon kebutuhan pasien secara cepat dan tepat, serta menjaga kualitas layanan dalam berbagai situasi, termasuk ketika menghadapi beban kerja tinggi atau kondisi darurat.

Aspek penting dari keandalan juga mencakup kemampuan perawat memenuhi janji pelayanan yang disampaikan, seperti ketepatan waktu, keteraturan, dan kesesuaian dengan harapan pasien. Kepercayaan pasien terbentuk ketika tenaga keperawatan mampu menunjukkan kinerja stabil dan dapat diandalkan setiap saat. Ciri perawat andal meliputi pengetahuan yang relevan dan terus diperbarui, keterampilan teknis yang terlatih, pengalaman kerja yang mendalam, serta kecakapan dalam memanfaatkan teknologi dan dokumentasi digital. Keandalan bukan hanya tanggung

jawab individu, tetapi juga bagian dari budaya organisasi yang menjunjung tinggi keselamatan pasien dan pelayanan berkelanjutan yang bermutu.

C. Indikator Mutu Pelayanan Keperawatan

Mutu pelayanan keperawatan sangat dipengaruhi oleh struktur, proses, dan hasil dari sistem pelayanan yang diterapkan di rumah sakit. Penilaian mutu ini juga mencakup sejauh mana pelayanan keperawatan dimanfaatkan oleh pasien, kualitas interaksi perawat dengan pasien, serta efisiensi dalam pemberian asuhan (Murray, 2017).

1. Aspek Struktur (*input*)

Aspek struktur mengacu pada seluruh komponen input yang mendasari terselenggaranya sistem pelayanan keperawatan di rumah sakit. Struktur ini mencakup berbagai elemen penting, seperti tenaga kerja (Manusia/MI) yang terdiri dari perawat dan tenaga kesehatan lainnya, sarana dan prasarana (M2) seperti ruang perawatan, peralatan medis, dan fasilitas pendukung, serta metode asuhan keperawatan (M3) yang mencerminkan pendekatan atau model keperawatan yang digunakan (misalnya, proses keperawatan atau pendekatan holistik). Pendanaan (M4) sebagai sumber daya finansial yang mendukung operasional pelayanan dan strategi pemasaran (M5) untuk menjangkau serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap mutu pelayanan keperawatan, juga merupakan bagian dari struktur sistem ini.

Ada keyakinan yang kuat bahwa struktur sistem yang tertata secara profesional akan memberikan dasar yang kokoh dalam menjamin mutu pelayanan keperawatan. Jika komponen-komponen struktur ini tersedia secara memadai, berkualitas, dan digunakan secara efisien, maka

perawat akan lebih mampu memberikan pelayanan yang efektif, aman, dan responsif terhadap kebutuhan pasien. Kecukupan jumlah perawat sesuai beban kerja, ketersediaan alat keperawatan yang memadai, serta adanya pedoman asuhan keperawatan berbasis bukti akan meningkatkan keandalan dan konsistensi pelayanan.

Penilaian kualitas struktur dalam konteks pelayanan keperawatan dilakukan dengan meninjau beberapa indikator, antara lain kewajaran dan kecukupan sumber daya manusia, kelengkapan fasilitas, efisiensi penggunaan dana, serta mutu prosedur dan metode asuhan keperawatan yang diterapkan. Penilaian ini menjadi penting karena struktur yang kuat menjadi fondasi utama untuk mencapai proses keperawatan yang optimal dan hasil asuhan yang bermutu tinggi.

Aspek struktur bukan hanya soal ketersediaan fisik atau jumlah tenaga kerja, melainkan juga mencerminkan kesiapan organisasi dalam menyediakan lingkungan yang mendukung praktik keperawatan profesional dan berfokus pada keselamatan serta kepuasan pasien. Struktur yang kuat akan mempermudah pelaksanaan proses pelayanan yang efektif dan menjadi jaminan awal terhadap mutu layanan keperawatan yang berkesinambungan.

2. Proses

Aspek proses merujuk pada seluruh rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, termasuk perawat, dokter, dan tenaga profesional lainnya, dalam memberikan pelayanan kepada pasien secara langsung. Proses ini mencakup interaksi profesional yang terjadi antara pemberi layanan dan pasien, yang bersifat dinamis, terstruktur, dan berdasarkan standar profesi serta etika

pelayanan kesehatan.

Aspek proses mencakup berbagai tahapan penting seperti pengkajian kondisi pasien, penetapan diagnosis keperawatan, perencanaan intervensi, pelaksanaan tindakan keperawatan, hingga evaluasi hasil asuhan. Seluruh tahapan tersebut disusun dalam suatu siklus yang dikenal sebagai proses keperawatan yang menjadi inti dari pelayanan keperawatan profesional. Proses ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek komunikasi terapeutik, empati, dan keterlibatan aktif pasien dalam pengambilan keputusan.

Mutu dari proses pelayanan dapat diukur melalui kejelasan dokumentasi asuhan, ketepatan waktu dan tindakan, kesesuaian antara diagnosis dan intervensi, serta konsistensi dalam penerapan standar prosedur operasional (SPO). Penting juga untuk mengevaluasi sejauh mana perawat mampu menjalin komunikasi yang efektif, bekerja secara kolaboratif dengan tim medis, serta memberikan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan fisik dan emosional pasien.

Aspek proses menjadi indikator penting dalam penilaian mutu karena meskipun struktur sudah mendukung, tanpa pelaksanaan proses yang benar dan profesional, pelayanan tidak akan menghasilkan outcome yang optimal. Rumah sakit harus memastikan bahwa setiap tenaga keperawatan dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mendukung praktik proses keperawatan secara konsisten, etis, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

3. *Outcome*

Aspek *outcome* merujuk pada hasil akhir dari seluruh proses pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan,

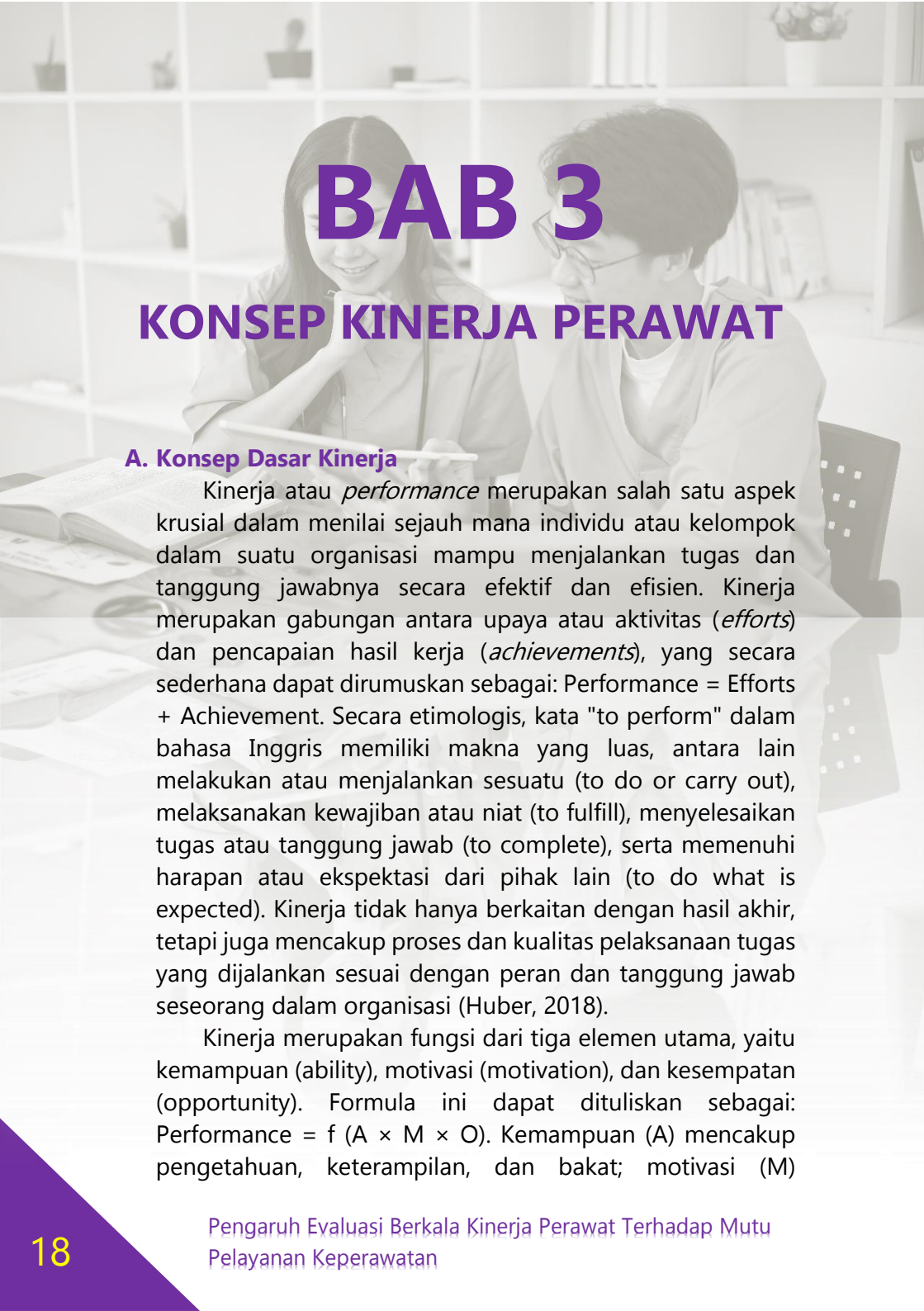
termasuk perawat. Hasil ini mencerminkan efektivitas pelayanan terhadap kondisi kesehatan pasien, dan biasanya diukur melalui berbagai indikator mutu. Indikator yang digunakan meliputi tingkat keberhasilan perawatan, angka kejadian komplikasi, serta tingkat kepuasan pasien dan keluarga. Indikator penting yang umum digunakan meliputi angka infeksi nosokomial (1–2%), kematian kasar (3–4%), kematian pasca bedah (1–2%), kematian ibu melahirkan (1–2%), dan kematian bayi baru lahir (20 per 1000 kelahiran hidup).

Outcome juga dievaluasi berdasarkan efisiensi operasional rumah sakit. Ini termasuk pengukuran seperti biaya per unit rawat jalan, angka kejadian dekubitus, pasien jatuh dari tempat tidur, dan rasio ketersediaan serta pemanfaatan tempat tidur seperti BOR (70–85%), BTO (40–50 kali per tahun), TOI (1–3 hari), dan LOS (7–10 hari). Data ini membantu menilai sejauh mana sumber daya digunakan secara optimal dan apakah pelayanan berlangsung sesuai standar efisiensi.

Tingkat kepuasan pasien juga merupakan bagian penting dari hasil pelayanan yang dapat diukur melalui jumlah keluhan langsung, surat pembaca, kotak saran, dan umpan balik lainnya. Sedangkan cakupan pelayanan dapat dilihat dari data jumlah kunjungan pasien rawat jalan atau rawat inap berdasarkan wilayah asal pasien, serta jumlah tindakan medis yang dilakukan. Penilaian outcome ini sebaiknya dibandingkan dengan standar nasional atau data tahun-tahun sebelumnya sebagai tolok ukur mutu.

Indikator keselamatan pasien juga sangat menentukan mutu pelayanan, seperti insiden pasien jatuh, kesalahan pemberian obat, ketidaksiapan alat

emergensi, atau kejadian medis yang tidak diharapkan. Beberapa indikator spesifik yang diadopsi dari rumah sakit besar seperti SGH (*Singapore General Hospital*) meliputi kejadian plebitis, dekubitus, pneumonia, dan kesalahan pemberian obat. Keselamatan pasien menjadi tolok ukur utama keberhasilan pelayanan keperawatan karena berkaitan langsung dengan risiko dan kualitas hidup pasien selama dirawat.



BAB 3

KONSEP KINERJA PERAWAT

A. Konsep Dasar Kinerja

Kinerja atau *performance* merupakan salah satu aspek krusial dalam menilai sejauh mana individu atau kelompok dalam suatu organisasi mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Kinerja merupakan gabungan antara upaya atau aktivitas (*efforts*) dan pencapaian hasil kerja (*achievements*), yang secara sederhana dapat dirumuskan sebagai: $\text{Performance} = \text{Efforts} + \text{Achievement}$. Secara etimologis, kata "to perform" dalam bahasa Inggris memiliki makna yang luas, antara lain melakukan atau menjalankan sesuatu (to do or carry out), melaksanakan kewajiban atau niat (to fulfill), menyelesaikan tugas atau tanggung jawab (to complete), serta memenuhi harapan atau ekspektasi dari pihak lain (to do what is expected). Kinerja tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir, tetapi juga mencakup proses dan kualitas pelaksanaan tugas yang dijalankan sesuai dengan peran dan tanggung jawab seseorang dalam organisasi (Huber, 2018).

Kinerja merupakan fungsi dari tiga elemen utama, yaitu kemampuan (ability), motivasi (motivation), dan kesempatan (opportunity). Formula ini dapat dituliskan sebagai: $\text{Performance} = f(A \times M \times O)$. Kemampuan (A) mencakup pengetahuan, keterampilan, dan bakat; motivasi (M)

mencakup dorongan internal seperti keinginan untuk berprestasi; dan kesempatan (O) mencerminkan lingkungan kerja, fasilitas, dan dukungan sistem yang memungkinkan seseorang dapat bekerja secara optimal. Pentingnya faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kinerja, seperti harapan terhadap imbalan (reward expectation), persepsi terhadap tugas, pengaruh dari pimpinan atau gaya kepemimpinan, kebutuhan dasar menurut hirarki Maslow, serta karakteristik pekerjaan itu sendiri yang meliputi desain kerja, umpan balik, pengawasan, dan pengendalian. Kinerja yang tinggi biasanya lahir dari kombinasi yang seimbang antara faktor individu dan organisasi (E. J. Sullivan, 2018).

Kinerja merupakan cerminan dari bagaimana tenaga kesehatan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesionalnya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. Hal ini tidak hanya dilihat dari seberapa cepat atau banyak tindakan keperawatan yang dilakukan, tetapi juga dari kualitas asuhan yang diberikan, kepuasan pasien, kepatuhan terhadap standar prosedur operasional, serta integritas moral dan etika yang dijunjung tinggi. Kinerja juga dapat dipahami sebagai perwujudan dari pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh. Sebagai bentuk realisasi dari visi, misi, dan strategi organisasi, kinerja berfungsi sebagai indikator utama keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Pengukuran kinerja secara sistematis dan berkelanjutan menjadi penting agar organisasi dapat melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan yang tepat (Murray, 2017).

Kepuasan kerja adalah sikap umum individu terhadap pekerjaannya. Pekerjaan bukan hanya soal menyelesaikan tugas administratif atau teknis, tetapi juga menyangkut interaksi dengan rekan kerja dan atasan, pemenuhan

terhadap aturan organisasi, serta adaptasi terhadap kondisi kerja yang tidak selalu ideal. Tingkat kepuasan kerja sering kali berkorelasi langsung dengan kinerja. Pegawai yang merasa puas dengan pekerjaannya cenderung menunjukkan performa yang lebih baik. Kinerja individu juga dipengaruhi oleh dua faktor penentu utama dalam organisasi, yaitu kepemimpinan dan sistem imbalan (yang berpengaruh melalui motivasi), serta pendidikan dan pelatihan (yang berpengaruh melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan). Ini sejalan dengan model perilaku X dari Fishbein (1979) yang menempatkan pengetahuan, sikap, dan niat sebagai dasar dari terbentuknya perilaku kerja (Dahlkemper, 2021).

Robbins mendefinisikan kinerja sebagai catatan hasil yang dicapai dalam menjalankan suatu fungsi atau tugas tertentu dalam kurun waktu tertentu. Kinerja yang baik ditandai dengan konsistensi dalam memenuhi target, kualitas output yang tinggi, serta kemampuan beradaptasi terhadap dinamika dan tantangan yang ada di tempat kerja. Banyak organisasi yang belum memiliki sistem informasi kinerja yang terstruktur. Beberapa manajer bahkan baru menyadari pentingnya evaluasi kinerja ketika situasi sudah memburuk. Padahal, informasi mengenai kinerja organisasi merupakan alat penting dalam memastikan bahwa seluruh proses dan kegiatan operasional telah berjalan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan (Qtait, 2023).

B. Kinerja Perawat

Kinerja perawat adalah keseluruhan hasil kerja yang dicapai oleh seorang perawat dalam melaksanakan tugas profesionalnya dalam memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan komunitas. Kinerja ini mencerminkan interaksi antara kemampuan, pengetahuan,

keterampilan, sikap, dan motivasi perawat dalam konteks sistem pelayanan kesehatan yang kompleks, serta sejauh mana tugas tersebut dilaksanakan secara konsisten, efektif, efisien, dan sesuai dengan standar profesi, kode etik, dan peraturan yang berlaku.

Kinerja merupakan kombinasi dari kemampuan (ability), motivasi (motivation), dan kesempatan (opportunity) yang dimiliki seseorang dalam mencapai tujuan tertentu. Kinerja perawat tidak hanya terbatas pada kegiatan teknis seperti memberikan obat, memantau tanda vital, atau melakukan tindakan keperawatan lainnya, melainkan juga mencakup aspek komunikasi terapeutik, empati, profesionalisme, dan kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya.

Kinerja perawat dinilai berdasarkan berbagai indikator, seperti ketepatan dalam melakukan pengkajian keperawatan, keakuratan dalam merumuskan diagnosa keperawatan, efektivitas dalam merancang rencana tindakan, keterampilan dalam mengimplementasikan intervensi, serta ketajaman dalam mengevaluasi hasil keperawatan. Evaluasi ini juga mencakup aspek keselamatan pasien, kepuasan pasien dan keluarga, dokumentasi yang sesuai, dan kontribusi terhadap pencapaian mutu pelayanan keperawatan secara keseluruhan.

Penilaian kinerja perawat merupakan bagian dari proses evaluasi terhadap efektivitas dan kelayakan intervensi keperawatan yang telah dilakukan. Standar proses keperawatan pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi digunakan sebagai tolak ukur formal dalam menilai kinerja perawat. Kinerja perawat juga dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, seperti tingkat pendidikan, pengalaman kerja, motivasi,

beban kerja, supervisi, iklim organisasi, serta sistem penghargaan dan insentif. Kinerja yang optimal hanya dapat dicapai jika perawat bekerja dalam lingkungan yang mendukung, memiliki akses terhadap pelatihan berkelanjutan, dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan keperawatan.

Kinerja perawat menjadi refleksi dari kualitas sumber daya manusia dalam pelayanan keperawatan yang berdampak langsung terhadap keselamatan pasien, efektivitas pelayanan, dan reputasi institusi pelayanan kesehatan. Evaluasi kinerja yang dilakukan secara sistematis, obyektif, dan berkelanjutan sangat penting untuk mendorong perawat meningkatkan profesionalismenya dan menjamin mutu asuhan keperawatan yang berfokus pada pasien secara menyeluruh baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual.

Penulis mengacu pada pedoman standar asuhan keperawatan yang telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Standar ini mencakup lima tahap utama dalam proses keperawatan yang harus dilakukan secara sistematis dan profesional oleh perawat dalam memberikan asuhan kepada pasien, yaitu: pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi (M. Sullivan & Hyland Robertson, 2020).

1. Pengkajian

Pengkajian merupakan tahap awal dalam proses keperawatan yang sangat krusial karena menjadi dasar dalam menentukan masalah kesehatan pasien. Tahapan ini mencakup kegiatan pengumpulan informasi menyeluruh mengenai kondisi pasien, baik secara subjektif (berdasarkan keluhan atau perasaan pasien) maupun objektif (melalui pengamatan dan pemeriksaan

fisik oleh perawat). Informasi yang dikumpulkan meliputi status fisiologis, psikologis, sosial, budaya, spiritual, dan gaya hidup pasien.

Pengumpulan data dilakukan secara sistematis dalam 24 jam pertama setelah pasien masuk ke rumah sakit dan menjadi tanggung jawab perawat yang merawat pasien tersebut. Analisis terhadap data yang diperoleh menjadi dasar dalam merumuskan diagnosa keperawatan yang akurat. Proses ini juga melibatkan penggunaan alat bantu asesmen seperti formulir pengkajian, lembar observasi, dan catatan medis pasien. Kualitas pengkajian yang komprehensif sangat mempengaruhi ketepatan diagnosa serta keberhasilan intervensi keperawatan yang akan dilakukan selanjutnya.

2. Penentuan Diagnosa

Diagnosa keperawatan adalah pernyataan profesional dari perawat mengenai masalah kesehatan pasien yang dapat diatasi melalui intervensi keperawatan. Diagnosa ini bukan sekadar identifikasi masalah medis, melainkan penilaian menyeluruh tentang respon pasien terhadap kondisi kesehatannya, baik secara aktual (nyata) maupun potensial (berisiko). Penulisan diagnosa keperawatan, digunakan format PES, yaitu:

- a. P (Problem): masalah utama yang diidentifikasi,
- b. E (Etiology): penyebab atau faktor yang berkontribusi terhadap masalah,
- c. S (Symptoms): gejala atau tanda-tanda yang mendukung identifikasi masalah tersebut.

Diagnosa harus dirumuskan berdasarkan prioritas klinis dan mempertimbangkan kondisi psikososial serta tingkat pengetahuan pasien. Diagnosa yang tepat akan memandu perawat dalam menyusun intervensi yang

terarah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Aspek penting lainnya adalah kemampuan perawat untuk membedakan antara diagnosa aktual dan risiko, serta menyusunnya dengan akurat dan sistematis.

3. Perencanaan Intervensi

Tahap perencanaan adalah proses di mana perawat menyusun rencana intervensi keperawatan yang spesifik dan realistis berdasarkan diagnosa yang telah ditetapkan. Rencana ini bertujuan untuk mencapai tujuan keperawatan yang terukur, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, serta memenuhi kebutuhan dasar pasien secara holistik. Langkah-langkah dalam perencanaan meliputi:

- a. Menetapkan prioritas masalah
- b. Merumuskan tujuan yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely)
- c. Menyusun rencana tindakan yang mencakup: observasi keperawatan, tindakan keperawatan mandiri, edukasi pasien dan keluarga, serta kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya.

Perencanaan yang baik juga melibatkan pasien dan keluarga dalam pengambilan keputusan, sehingga meningkatkan partisipasi mereka dalam proses penyembuhan. Rencana keperawatan harus terdokumentasi dengan baik dan dikembangkan oleh perawat yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap pasien.

4. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan semua rencana tindakan keperawatan yang telah disusun sebelumnya dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan

pasien. Tahapan ini menuntut perawat untuk memiliki keterampilan teknis, komunikasi, dan interpersonal yang baik, serta kepekaan terhadap kenyamanan, keselamatan, dan hak pasien. Langkah implementasi mencakup:

- a. Persiapan: termasuk pengecekan alat, bahan, dan kesiapan pasien,
- b. Pelaksanaan tindakan: dilakukan sesuai standar prosedur operasional (SPO), mengutamakan prinsip keamanan, etika, dan empati.

Jenis tindakan yang dilakukan dapat berupa: observasi terhadap kondisi pasien, tindakan keperawatan seperti perawatan luka atau pemberian obat, penyuluhan kesehatan kepada pasien dan keluarganya, serta kolaborasi dengan tenaga medis lainnya. Respons pasien terhadap tindakan juga harus dicatat untuk menjadi bahan evaluasi pada tahap selanjutnya.

5. Evaluasi

Evaluasi merupakan tahap akhir dalam proses keperawatan yang bertujuan untuk menilai efektivitas dari tindakan keperawatan yang telah dilakukan serta pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses evaluasi dilakukan secara berkelanjutan dan dinamis, sesuai dengan perkembangan kondisi pasien. Langkah-langkah dalam evaluasi meliputi:

- a. Mengumpulkan data terbaru terkait perkembangan kondisi pasien
- b. Membandingkan antara kondisi awal dan setelah tindakan keperawatan dilakukan
- c. Menilai apakah tujuan keperawatan telah tercapai sepenuhnya, sebagian tercapai, atau tidak tercapai.

Evaluasi juga menjadi dasar untuk mengkaji ulang rencana keperawatan. Bila diperlukan, diagnosa dan rencana tindakan bisa dimodifikasi agar lebih sesuai dengan kondisi aktual pasien. Diagnosa yang sudah teratasi perlu didokumentasikan dengan jelas, sedangkan diagnosa yang masih bermasalah harus terus dievaluasi dan diberikan tindakan lanjutan.

C. Indikator Kinerja Perawat

Kinerja merupakan representasi konkret dari tindakan dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang berkaitan dengan peran serta posisinya di suatu organisasi atau institusi, termasuk di dalamnya layanan kesehatan seperti rumah sakit. Kinerja tidak hanya mencerminkan hasil akhir dari pekerjaan yang dilakukan, tetapi juga menggambarkan proses, sikap, dan kualitas keterlibatan individu dalam menyelesaikan tugas. Kinerja perawat menjadi indikator penting dalam menentukan mutu layanan yang diterima oleh pasien. Terdapat tiga kategori utama yang memengaruhi kinerja seseorang, yaitu faktor individu, psikologis, dan organisasi.

Faktor individu mencakup unsur-unsur yang bersifat personal seperti kemampuan teknis dan nonteknis, keterampilan klinis, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja sebelumnya, serta status sosial ekonomi dan demografi seseorang. Faktor ini menentukan sejauh mana seseorang mampu memahami, menyesuaikan diri, dan menyelesaikan pekerjaan sesuai standar profesi. Perawat yang memiliki pengalaman luas dan pelatihan yang memadai akan lebih mampu memberikan asuhan yang tepat, cepat, dan berkualitas.

Faktor psikologis terdiri dari persepsi individu terhadap pekerjaan, peran dan tanggung jawab yang

diemban, sikap kerja, kepribadian, motivasi internal, serta tingkat kepuasan kerja. Faktor ini sangat berpengaruh terhadap semangat dan dedikasi perawat dalam memberikan pelayanan. Perawat yang memiliki motivasi tinggi dan kepuasan kerja yang baik umumnya menunjukkan tingkat empati yang lebih tinggi terhadap pasien, lebih aktif dalam berkolaborasi, dan mampu bekerja dengan konsisten meskipun dalam tekanan.

Adapun faktor organisasi meliputi struktur organisasi tempat perawat bekerja, peran dan fungsi kepemimpinan dalam unit kerja, perancangan pekerjaan (job design), serta sistem penghargaan atau reward system yang diterapkan oleh institusi. Organisasi yang memiliki sistem pendukung yang baik akan mendorong perawat untuk bekerja lebih efektif, efisien, dan loyal terhadap profesinya. Untuk memperjelas dimensi kinerja maka dapat dikelompokkan ke dalam beberapa indikator utama dimensi kinerja perawat (Bramlett, 2018):

1. *Quantity of Work* (Kuantitas Kerja)

Dimensi ini mengacu pada jumlah atau volume pekerjaan yang mampu diselesaikan oleh perawat dalam kurun waktu tertentu, misalnya per hari, per shift, atau per minggu. Dalam praktik keperawatan, kuantitas kerja bisa terlihat dari jumlah pasien yang dilayani, jumlah dokumentasi asuhan keperawatan yang dituntaskan, atau jumlah prosedur keperawatan yang dilakukan sesuai dengan standar. Kuantitas yang tinggi harus tetap diimbangi dengan kualitas agar pelayanan tetap efektif dan tidak sekadar mengejar target.

2. *Quality of Work* (Kualitas Kerja)

Aspek ini menilai seberapa baik hasil pekerjaan perawat dalam memenuhi standar mutu pelayanan. Hal

ini mencakup ketepatan tindakan keperawatan, kecermatan dalam pencatatan, dan kesesuaian prosedur dengan standar operasional. Kualitas kerja juga berkaitan dengan kepuasan pasien, keamanan layanan, serta kemampuan perawat dalam mencegah terjadinya kesalahan (error). Seorang perawat yang bekerja dengan kualitas tinggi akan mampu memberikan asuhan yang aman, tepat, dan sesuai etika profesi.

3. *Job Knowledge* (Pengetahuan Kerja)

Dimensi ini mengukur sejauh mana perawat menguasai teori keperawatan, standar prosedur operasional (SPO), dan pengetahuan praktis yang relevan dengan tugasnya. Hal ini mencakup pemahaman tentang kondisi pasien, manajemen nyeri, pemberian obat, serta dokumentasi asuhan keperawatan. Pengetahuan kerja yang baik memungkinkan perawat membuat keputusan klinis yang cepat dan tepat, serta menjadi dasar dalam memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga.

4. *Creativeness* (Kreativitas)

Kreativitas dalam keperawatan bukan hanya soal ide baru, tetapi kemampuan untuk berpikir kritis dan fleksibel dalam menghadapi situasi kompleks, darurat, atau tidak terduga. Perawat yang kreatif mampu mencari solusi inovatif dalam menyelesaikan masalah keperawatan, misalnya dengan melakukan pendekatan komunikasi yang berbeda, memodifikasi teknik intervensi sesuai kondisi pasien, atau menciptakan alat bantu sederhana. Kreativitas sangat dibutuhkan terutama dalam kondisi sumber daya terbatas.

5. *Cooperation* (Kerja Sama)

Kemampuan bekerja dalam tim merupakan dimensi penting, mengingat keperawatan tidak dapat dilakukan

secara individual. Perawat harus mampu menjalin komunikasi efektif, berbagi informasi yang relevan, serta mendukung rekan sejawat dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan holistik. Sikap kooperatif juga mencerminkan loyalitas terhadap institusi dan kepedulian terhadap keselamatan pasien.

6. *Dependability* (Keandalan)

Keandalan berkaitan dengan tanggung jawab, ketepatan waktu, serta kemampuan perawat untuk konsisten dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Perawat yang andal akan hadir tepat waktu, mengikuti jadwal shift, menyelesaikan dokumentasi dengan cermat, dan menjaga kontinuitas pelayanan kepada pasien. Perawat juga dapat diandalkan untuk menjaga kerahasiaan pasien serta menjalankan tugas meski tanpa pengawasan langsung.

7. *Initiative* (Inisiatif)

Dimensi ini menunjukkan dorongan internal perawat untuk bertindak tanpa harus selalu disuruh. Inisiatif mencakup keberanian mengambil tindakan dini, usulan perbaikan layanan, dan keterlibatan aktif dalam kegiatan pengembangan profesi. Seorang perawat dengan inisiatif tinggi tidak hanya melakukan tugas rutin, tetapi juga bersedia mengambil peran lebih, seperti menjadi mentor bagi rekan baru atau ikut serta dalam penyusunan SOP.

8. *Personal Qualities* (Kualitas Pribadi)

Aspek ini mencerminkan integritas moral, keramahan, empati, sikap sopan santun, serta etika profesional yang ditunjukkan dalam keseharian. Kualitas pribadi yang baik menjadi dasar dalam membangun hubungan terapeutik dengan pasien dan keluarga. Perawat yang memiliki sikap positif dan kepribadian yang

menyenangkan akan lebih mudah diterima oleh pasien, serta mampu menciptakan suasana kerja yang harmonis dan kolaboratif.

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Perawat

Kinerja perawat merupakan indikator penting dalam menentukan kualitas pelayanan keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Kinerja yang optimal bukan hanya ditentukan oleh kemampuan individu semata, melainkan juga oleh berbagai faktor lain yang saling berinteraksi dalam sistem organisasi. Menurut berbagai literatur keperawatan dan manajemen sumber daya manusia, setidaknya terdapat lima kelompok faktor utama yang memengaruhi kinerja perawat, yaitu faktor personal/individu, faktor kepemimpinan, faktor tim, faktor sistem organisasi, dan faktor kontekstual atau situasional. Berikut penjelasannya secara lebih mendalam (Sullivan, 2018):

1. Faktor personal/individu

Faktor ini berkaitan dengan kapasitas dan karakteristik pribadi yang dimiliki oleh masing-masing perawat. Kinerja perawat sangat bergantung pada sejauh mana individu memiliki kualitas berikut:

- a. Pengetahuan (Knowledge): Pemahaman perawat terhadap ilmu keperawatan, standar asuhan, prosedur klinis, dan etika profesi akan menentukan kualitas layanan yang mereka berikan. Pengetahuan yang memadai memungkinkan pengambilan keputusan klinis yang tepat.
- b. Keterampilan dan kemampuan teknis (Skill & Competency): keterampilan teknis dalam melakukan tindakan keperawatan (misalnya, injeksi, perawatan

luka, pemasangan infus) dan kemampuan berpikir kritis dalam situasi darurat.

- c. Kepercayaan diri (Self-confidence): Perawat yang memiliki rasa percaya diri tinggi cenderung lebih sigap, tidak ragu dalam mengambil tindakan, serta memiliki daya adaptasi yang baik di lingkungan kerja yang dinamis.
- d. Motivasi (Motivation): Dorongan dari dalam diri untuk bekerja dengan baik. Perawat yang termotivasi akan lebih antusias, bertanggung jawab, dan fokus pada kepuasan pasien.
- e. Komitmen (Commitment): Kesungguhan dalam menjalankan peran dan tanggung jawab profesional, termasuk kepatuhan terhadap aturan organisasi, etika profesi, dan keterlibatan aktif dalam tim.
- f. Kesehatan fisik dan mental: Kondisi fisik dan psikologis perawat sangat berpengaruh pada kinerja. Perawat yang mengalami kelelahan, stres, atau gangguan kesehatan akan sulit memberikan pelayanan yang optimal.

2. Faktor kepemimpinan

Kepemimpinan berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung peningkatan kinerja perawat. Beberapa aspek penting dari faktor kepemimpinan antara lain:

- a. Gaya Kepemimpinan Kepala Ruangan atau Manajer Keperawatan: Gaya kepemimpinan transformasional, partisipatif, atau suportif terbukti meningkatkan

kepuasan kerja dan kinerja staf keperawatan.

- b. Kemampuan Memberikan Arahan dan Umpan Balik: Pemimpin yang mampu memberikan arahan kerja yang jelas dan umpan balik konstruktif akan mendorong perawat untuk terus meningkatkan kualitas pekerjaannya.
 - c. Pemberian Dukungan Emosional dan Fasilitasi: Pemimpin yang peka terhadap kebutuhan staf, serta memberikan dukungan di saat stres atau tekanan tinggi, akan meningkatkan semangat dan loyalitas perawat.
 - d. Keteladanan dan Integritas: Pemimpin yang konsisten antara perkataan dan tindakan serta menunjukkan etika kerja yang baik akan menjadi panutan bagi perawat lainnya.
3. Faktor tim

Kinerja individu sangat dipengaruhi oleh dinamika tim di mana ia bekerja. Dalam pelayanan keperawatan, yang bersifat kolaboratif, faktor tim sangat menentukan:

- a. Dukungan rekan kerja: Semangat dan bantuan dari rekan sejawat dapat mendorong perawat bekerja lebih efisien dan percaya diri, terutama dalam shift yang padat.
- b. Kepercayaan dan kekompakan: Tim yang saling percaya dan solid akan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif, serta mampu menghadapi tekanan bersama-sama.
- c. Komunikasi efektif: Komunikasi yang terbuka, jujur,

dan asertif antaranggota tim sangat diperlukan dalam pertukaran informasi, koordinasi asuhan, serta pengambilan keputusan klinis.

- d. Budaya kerja tim: Tim yang memiliki budaya saling menghargai, kolaboratif, dan saling menguatkan akan meningkatkan produktivitas, kepuasan kerja, dan loyalitas staf.

4. Faktor sistem dan organisasi

Sistem kerja yang diterapkan oleh organisasi juga memegang peran krusial dalam mendukung atau menghambat kinerja perawat. Faktor-faktor tersebut meliputi:

- a. Ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana: Ruang kerja yang nyaman, alat medis yang lengkap, sistem dokumentasi elektronik yang efisien akan meningkatkan performa dan mengurangi beban kerja perawat.
- b. Sistem manajemen SDM: Termasuk dalam hal ini adalah perencanaan SDM, sistem absensi, rotasi kerja, serta kebijakan cuti dan pengembangan karier.
- c. Proses dan SOP Organisasi: Prosedur tetap (SOP) yang jelas dan terstandarisasi memberikan pedoman kerja yang seragam, mencegah kesalahan, dan memastikan kualitas pelayanan.
- d. Budaya organisasi dan etos kerja: Budaya organisasi yang positif seperti budaya mutu, budaya keselamatan pasien, serta budaya kolaborasi akan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan mendukung kinerja

optimal.

- e. Sistem penghargaan dan evaluasi kinerja: Reward yang diberikan secara adil atas kinerja yang baik (baik berupa penghargaan non-material maupun insentif finansial) dapat meningkatkan motivasi dan loyalitas perawat.

5. Faktor Kontekstual/Situasional

Kondisi eksternal dan internal yang berubah-ubah juga dapat memengaruhi stabilitas dan konsistensi kinerja perawat. Faktor kontekstual ini mencakup:

- a. Tekanan lingkungan kerja: Seperti tingginya beban pasien, tuntutan administrasi yang tinggi, keterbatasan waktu, dan kondisi darurat dapat memengaruhi kualitas kerja perawat.
- b. Perubahan kebijakan dan regulasi: Misalnya, perubahan standar akreditasi rumah sakit, kebijakan Kementerian Kesehatan, atau regulasi BPJS Kesehatan dapat menuntut penyesuaian cepat dari para perawat.
- c. Kondisi sosial dan keluarga: Masalah pribadi, keluarga, atau kondisi sosial ekonomi juga dapat memengaruhi fokus dan konsentrasi perawat dalam menjalankan tugasnya.
- d. Krisis atau kejadian luar biasa: Pandemi, bencana alam, atau situasi kegawatdaruratan massal dapat menambah tekanan yang signifikan terhadap kinerja perawat.

E. Pengukuran Kinerja Perawat

Penerapan metode pengukuran kinerja perawat yang bisa menjadi standar di sebuah organisasi menjadi penting dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, Metode penilaian ini bisa dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu (Bramlett, 2018):

1. Evaluasi Kinerja Berbasis Hasil (Result-Based Performance Evaluation)

Metode ini menekankan pada pencapaian target atau hasil kerja yang terukur dan spesifik. Fokus utama dari evaluasi ini adalah seberapa efektif perawat dalam mencapai sasaran kerja yang telah ditentukan sebelumnya, baik secara individu maupun sebagai bagian dari tim. Sasaran tersebut bisa berupa jumlah pasien yang ditangani, efektivitas dalam pelaksanaan intervensi keperawatan, atau capaian indikator mutu layanan. Evaluasi berbasis hasil juga dikenal dengan pendekatan Manajemen Berdasarkan Tujuan (Management by Objectives - MBO), dimana indikator keberhasilan kerja diukur melalui capaian nyata, bukan sekadar upaya. Metode ini dinilai mampu meningkatkan produktivitas, karena mendorong perawat untuk bekerja secara lebih terfokus, efisien, dan selaras dengan tujuan organisasi pelayanan kesehatan. Keberhasilan metode ini sangat bergantung pada kejelasan target, sistem pelaporan yang transparan, dan konsistensi pengukuran kinerja secara berkala.

2. Evaluasi Kinerja Berbasis Perilaku (Behavior-Based Performance Evaluation)

Jenis evaluasi ini mengukur kinerja perawat bukan dari hasil akhir semata, tetapi dari proses kerja dan perilaku kerja selama memberikan pelayanan

keperawatan. Ini termasuk sikap terhadap pasien, kemampuan komunikasi interpersonal, kedisiplinan, perhatian terhadap detail, serta inisiatif dalam mengatasi masalah. Penilaian berbasis perilaku mengapresiasi usaha dan dedikasi perawat dalam situasi yang kompleks atau dinamis, bahkan ketika hasil akhir belum optimal karena faktor eksternal. Tantangan utama metode ini adalah tingkat subjektivitas penilaian yang tinggi, karena perilaku kerja sering kali bersifat kualitatif dan memerlukan pengamatan langsung. Evaluator harus diberikan pelatihan dan pedoman yang jelas agar penilaian tetap objektif dan adil. Evaluasi berbasis perilaku sangat penting dalam profesi keperawatan karena mencerminkan nilai-nilai humanistik dan etika profesional yang tidak selalu tercermin dari hasil kerja semata.

3. Evaluasi Kinerja Berbasis Penilaian Profesional atau Penilaian Subjektif (Judgement-Based Performance Evaluation)

Penilaian dilakukan berdasarkan pengamatan dan penilaian profesional dari atasan langsung atau evaluator terhadap perilaku dan kemampuan kerja perawat dalam berbagai aspek. Evaluasi mencakup indikator seperti jumlah dan kualitas pekerjaan yang diselesaikan, pemahaman terhadap tugas, pengetahuan teknis, kemampuan bekerja dalam tim, keandalan, tanggung jawab, kreativitas, serta kualitas pribadi seperti integritas dan etika kerja. Evaluasi ini sering disusun dalam bentuk deskripsi perilaku atau skala penilaian dengan kategori tertentu (misalnya sangat baik, baik, cukup, kurang) yang memungkinkan pemberi penilaian memberikan komentar kualitatif. Keunggulan metode ini adalah fleksibilitas dan ruang bagi evaluator untuk menilai aspek-aspek yang

tidak bisa diukur secara kuantitatif. Tantangannya adalah potensi bias personal atau bias relasi jika tidak dilakukan dengan transparan dan terstandarisasi. Evaluasi berbasis judgement sebaiknya disertai instrumen yang valid dan reliabel serta melibatkan proses umpan balik dari perawat yang dinilai.

Ketiga metode evaluasi kinerja di atas memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan dalam praktiknya sering kali digunakan secara kombinatorial agar dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja perawat. Evaluasi berbasis hasil cocok untuk mengukur produktivitas, evaluasi berbasis perilaku menguatkan aspek proses dan etika kerja, sedangkan evaluasi berbasis judgement memberi ruang untuk penilaian menyeluruh atas kualitas personal dan profesional perawat. Organisasi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit sebaiknya mengembangkan sistem evaluasi kinerja yang komprehensif, transparan, dan berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia, sehingga mampu meningkatkan mutu pelayanan keperawatan secara berkelanjutan.

F. Upaya Meningkatkan Kinerja Perawat

Kinerja perawat merupakan salah satu faktor kunci dalam menentukan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas, maupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Untuk memastikan bahwa perawat dapat bekerja secara profesional, produktif, dan sesuai dengan standar, maka diperlukan suatu kerangka kerja yang jelas dan sistematis, salah satunya melalui penetapan deskripsi jabatan (*job description*) yang terstruktur dan terarah. Beberapa upaya untuk meningkatkan kinerja perawat yaitu (Sullivan, 2018):

1. Penentuan gaji yang adil dan objektif

Deskripsi jabatan memungkinkan organisasi menetapkan struktur penggajian secara objektif berdasarkan tingkat tanggung jawab, risiko kerja, beban kerja, dan kompleksitas tugas yang dijalankan oleh perawat, misalnya perawat di ruang intensif (ICU) atau instalasi gawat darurat (IGD) memiliki tanggung jawab dan tuntutan kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan perawat di ruang rawat inap umum, sehingga perbedaan ini harus tercermin dalam sistem kompensasi. Adanya deskripsi jabatan yang rinci, maka pengambilan keputusan terkait pemberian insentif, tunjangan kinerja, maupun penghargaan dapat dilakukan secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja perawat.

2. Seleksi dan rekrutmen perawat yang tepat sasaran

Deskripsi jabatan dalam proses perekrutan perawat baru, membantu memetakan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan. Hal ini penting agar proses seleksi tidak hanya berfokus pada kualifikasi akademik semata, tetapi juga mempertimbangkan soft skill, etika profesi, dan kemampuan teknis yang relevan dengan posisi yang dibutuhkan. Sebagai contoh yaitu perawat yang akan ditempatkan di ruang bedah tentu harus memiliki pemahaman dasar tentang prinsip sterilitas, prosedur intraoperatif, dan keterampilan berkolaborasi dengan tim medis. Tanpa deskripsi jabatan yang jelas, proses seleksi bisa menjadi tidak terarah dan menimbulkan ketidaksesuaian antara personil dan jabatan.

3. Orientasi dan adaptasi karyawan baru yang efektif

Deskripsi jabatan menjadi dasar bagi pelaksanaan program orientasi dan masa percobaan bagi perawat baru. Dengan informasi yang jelas tentang tugas, batasan wewenang, alur pelaporan, dan indikator kinerja, maka perawat dapat beradaptasi lebih cepat dengan lingkungan kerja dan budaya organisasi. Perawat baru yang memahami deskripsi jabatannya akan lebih mudah menyesuaikan diri, menghindari kesalahan komunikasi, dan menjalankan tugas dengan percaya diri. Ini akan mengurangi risiko kesalahan klinis dan meningkatkan efisiensi kerja sejak awal penempatan.

4. Penilaian kinerja perawat yang terukur

Deskripsi jabatan berfungsi sebagai dasar untuk menyusun indikator kinerja individu (IKI) yang spesifik dan realistis. Hal ini memungkinkan supervisor atau kepala ruangan melakukan penilaian kinerja perawat secara obyektif, adil, dan berbasis bukti. Kinerja perawat tidak lagi dinilai secara subjektif, tetapi mengacu pada standar kinerja yang telah disepakati sesuai dengan jabatan yang diemban.

Penilaian ini juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk promosi, rotasi, mutasi, atau pengembangan kompetensi. Ketika penilaian kinerja didasarkan pada deskripsi jabatan, maka perawat akan lebih mudah mengevaluasi dirinya dan mengembangkan rencana perbaikan (improvement plan) secara pribadi maupun tim.

5. Pelatihan dan Pengembangan Karier Perawat

Deskripsi jabatan membantu manajemen keperawatan dalam merancang program pelatihan dan pengembangan yang tepat guna. Dengan mengetahui

kompetensi yang dibutuhkan dalam setiap posisi, maka pelatihan dapat diarahkan untuk menutup kesenjangan kompetensi (competency gap) serta mendukung pencapaian jenjang karier yang diinginkan. Sebagai contoh yaitu perawat yang akan dipromosikan menjadi kepala ruangan perlu diberikan pelatihan tentang manajemen mutu, supervisi klinik, serta komunikasi kepemimpinan. Tanpa deskripsi jabatan yang memadai, pelatihan sering kali bersifat umum dan tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

6. Perencanaan organisasi dan pembagian tugas yang seimbang

Deskripsi jabatan mendukung penyusunan struktur organisasi keperawatan yang rasional, fungsional, dan seimbang. Informasi yang jelas tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing posisi, maka dapat dihindari tumpang tindih peran, beban kerja yang tidak merata, atau area kerja yang tidak terkelola. Contohnya yaitu dengan deskripsi jabatan yang tepat, perawat pelaksana tidak akan dibebani tugas administrasi kepala ruangan, dan sebaliknya, kepala ruangan tidak terjebak pada pekerjaan teknis yang seharusnya bisa didelegasikan. Ini memungkinkan koordinasi antarunit lebih efisien dan pelayanan kepada pasien menjadi lebih optimal.

7. Pemahaman tanggung jawab individual

Deskripsi jabatan memungkinkan setiap perawat memahami dengan jelas apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawabnya, termasuk batasan wewenang, hubungan kerja dengan tim, serta alur pelaporan. Hal ini penting dalam menciptakan rasa kepemilikan terhadap pekerjaan (sense of ownership)

dan meningkatkan akuntabilitas dalam praktik keperawatan. Perawat yang memahami tanggung jawabnya cenderung lebih disiplin, inisiatif, dan berhati-hati dalam menjalankan prosedur, karena mereka tahu bahwa setiap tindakan akan berdampak langsung terhadap keselamatan pasien dan reputasi profesional mereka



BAB 4

PENGENDALIAN PELAYANAN KEPERAWATAN

A. Pengertian Pengendalian Pelayanan Keperawatan

Pengendalian merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen yang berperan dalam memastikan bahwa setiap aktivitas berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian sebagai suatu proses sistematis dalam mengevaluasi segala kegiatan yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan rencana awal, instruksi dari atasan, dan prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Dalam pandangannya, pengendalian tidak hanya sekadar pemeriksaan akhir, tetapi juga menyangkut kesesuaian setiap langkah yang dijalankan selama proses berlangsung (Cristina, Nogueira, Oliveira, & Santos, 2024).

Pengendalian merupakan suatu upaya sistematis yang mencakup penetapan standar kinerja berdasarkan tujuan perencanaan, penyusunan sistem umpan balik informasi (feedback system), serta perbandingan antara kinerja aktual dan standar yang telah ditentukan. Apabila ditemukan penyimpangan (deviasi), maka perlu dilakukan analisis terhadap tingkat signifikansi penyimpangan tersebut untuk

selanjutnya diambil langkah korektif yang sesuai. Pengendalian berperan aktif dalam proses perbaikan berkelanjutan terhadap pencapaian tujuan organisasi (Leso, Cortimiglia, & Ghezzi, 2023).

Pengendalian memiliki peranan yang sangat vital dalam menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan. Pengendalian di sini diartikan sebagai proses untuk mengukur kinerja atau hasil kerja perawat berdasarkan standar atau indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara hasil aktual dengan standar yang diharapkan, maka perlu dilakukan tindakan korektif agar pelayanan tetap berada dalam koridor mutu yang diharapkan. Hal ini menegaskan bahwa pengendalian bukanlah aktivitas yang hanya dilakukan pada akhir siklus kerja, melainkan diintegrasikan pada setiap tahapan proses keperawatan (Yang, 2022).

Sama halnya dengan proses keperawatan yang bersifat siklikal dan berkesinambungan, fungsi pengendalian juga harus diterapkan secara berkelanjutan pada setiap tahap manajemen keperawatan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi. Pengendalian menjadi instrumen penting untuk menilai efektivitas dan efisiensi setiap langkah kerja yang dilakukan oleh tim keperawatan. Pengendalian ini dikenal dengan istilah kendali mutu (quality control). Kendali mutu dalam keperawatan mengacu pada serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mengevaluasi, memonitor, dan mengatur pelaksanaan asuhan keperawatan agar pelayanan yang diberikan kepada pasien memenuhi standar mutu yang telah ditentukan. Organisasi keperawatan tidak hanya mampu menjamin kualitas pelayanan, tetapi juga memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan sejalan dengan visi dan misi

organisasi (Aini, 2018).

Untuk melaksanakan fungsi pengendalian secara optimal, seorang perawat manajer dituntut memiliki keterampilan manajerial dan kepemimpinan yang memadai. Mereka harus mampu menyusun standar, melakukan pengawasan yang objektif, menganalisis penyimpangan kinerja, serta menyusun rencana tindak lanjut yang konstruktif. Pengendalian dalam manajemen keperawatan merupakan fungsi yang kompleks dan membutuhkan kombinasi antara pengetahuan manajemen, kemampuan analitis, serta kepemimpinan yang visioner untuk menciptakan layanan keperawatan yang aman, efektif, dan bermutu tinggi.

B. Manfaat Pengendalian Pelayanan Keperawatan

Pengendalian mutu dalam keperawatan merupakan aspek penting dalam manajemen keperawatan yang bertujuan untuk menjamin tercapainya standar pelayanan yang optimal. Pelaksanaan pengendalian mutu yang sistematis memberikan berbagai manfaat strategis, khususnya bagi manajer keperawatan dalam mengelola dan mengevaluasi kinerja perawat maupun efektivitas operasional unit kerja. Beberapa manfaat tersebut antara lain (Hidaya, Alfianur, & Handayani, 2020):

1. Memantau pelaksanaan tugas keperawatan secara efektif

Manajer keperawatan melalui pengendalian mutu memiliki akses terhadap informasi yang akurat mengenai kegiatan dan tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan oleh para staf dalam kurun waktu tertentu. Manajer dapat mengevaluasi apakah tugas yang diberikan telah dijalankan sesuai dengan prosedur operasional standar (SPO), rencana asuhan keperawatan, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Informasi ini

menjadi dasar untuk melakukan analisis kinerja serta perencanaan tindakan perbaikan yang diperlukan.

2. Mengidentifikasi kesalahan pemahaman dan penyimpangan prosedur

Pengendalian mutu membantu manajer dalam mendeteksi adanya miskonsepsi atau kekeliruan pemahaman terhadap kebijakan, prosedur, maupun intervensi keperawatan yang dapat mengakibatkan penyimpangan dalam praktik. Manajer dapat segera mengambil langkah korektif melalui pelatihan ulang, supervisi langsung, atau perbaikan sistem kerja agar kualitas pelayanan tidak terganggu.

3. Menilai efektivitas penggunaan waktu dan sumber daya

Salah satu aspek penting dalam pengendalian mutu adalah kemampuan untuk menilai apakah sumber daya baik tenaga, waktu, maupun alat dan bahan telah digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Manajer dapat mengevaluasi apakah proses pelayanan berjalan secara hemat biaya, tidak membuang waktu, dan tidak menimbulkan pemborosan. Ini sangat penting dalam mendukung efisiensi operasional rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya.

4. Mendeteksi penyimpangan dan menelusuri akar masalahnya

Manfaat lainnya adalah kemampuan untuk mengidentifikasi penyimpangan sejak dini serta menggali penyebab mendasarnya, dimana menemukan penyimpangan dan memahami faktor-faktor yang memicunya baik dari aspek individu, sistem, maupun lingkungan kerja, memungkinkan manajer keperawatan dapat mengembangkan strategi pencegahan dan perbaikan yang tepat. Hal ini juga mendukung budaya

keselamatan pasien (patient safety) dan peningkatan mutu berkelanjutan.

5. Menentukan perawat yang perlu diberi apresiasi maupun pengawasan

Pengendalian mutu memungkinkan manajer keperawatan untuk membedakan antara staf yang menunjukkan kinerja baik dan konsisten dengan standar, serta staf yang masih memerlukan bimbingan atau pengawasan lebih lanjut. Informasi ini sangat berguna dalam pengambilan keputusan terkait pemberian penghargaan, promosi, maupun kebutuhan pelatihan tambahan. Evaluasi berbasis pengendalian mutu dapat meningkatkan motivasi kerja staf dan menciptakan lingkungan kerja yang adil dan transparan.

C. Prinsip Pengendalian Pelayanan Keperawatan

Prinsip-prinsip pengawasan dalam manajemen keperawatan berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan pelayanan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Manajer keperawatan sebagai pemimpin di unit keperawatan memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan pengawasan secara sistematis dan terarah. Beberapa prinsip penting yang harus dijalankan meliputi (M. Sullivan & Hyland Robertson, 2020):

1. Pengawasan yang transparan, dipahami, dan terukur oleh seluruh staf

Pengawasan yang dilakukan oleh manajer keperawatan haruslah bersifat jelas, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan kebingungan di kalangan staf keperawatan. Proses pengawasan tidak boleh bersifat terselubung atau membingungkan, melainkan harus dijelaskan dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif. Hasil dari proses pengawasan harus dapat

diukur secara objektif menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga setiap staf mengetahui parameter yang menjadi dasar evaluasi dan penilaian kerja mereka.

2. Pengendalian sebagai sarana pencapaian tujuan, bukan alat hukuman

Seorang manajer keperawatan yang efektif harus mampu membangun persepsi positif terhadap kegiatan pengawasan di lingkungan kerja. Salah satu prinsip yang sangat penting adalah meyakinkan seluruh staf bahwa pengawasan dan pengendalian bukan dilakukan untuk mencari kesalahan atau menghukum, melainkan sebagai sarana untuk membantu staf mencapai tujuan unit dan organisasi secara keseluruhan. Ketika pengawasan dilakukan dengan pendekatan yang membangun, staf akan lebih terbuka terhadap umpan balik dan lebih termotivasi untuk memperbaiki kinerja mereka.

3. Sosialisasi dan penjelasan standar kinerja secara menyeluruh

Pengawasan yang efektif memerlukan pemahaman bersama mengenai standar kinerja yang diharapkan. Manajer keperawatan harus secara aktif mensosialisasikan dan menjelaskan standar kerja kepada seluruh anggota tim keperawatan. Standar ini bisa mencakup prosedur pelayanan, indikator mutu, serta etika dan profesionalisme dalam bekerja. Setelah sosialisasi dilakukan manajer perlu melakukan penilaian terhadap kinerja staf secara berkala untuk memantau sejauh mana pencapaian masing-masing individu terhadap standar tersebut. Hasil evaluasi ini tidak hanya menjadi dasar untuk memberikan umpan balik, tetapi juga digunakan untuk menetapkan pemberian reward

kepada staf yang menunjukkan dedikasi dan profesionalisme tinggi, serta peringatan atau bimbingan lanjutan kepada staf yang kinerjanya belum sesuai harapan.

D. Langkah-Langkah Pengendalian Pelayanan Keperawatan

Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan utamanya yaitu memberikan asuhan keperawatan yang bermutu, sangat bergantung pada peran aktif manajer keperawatan dalam mengimplementasikan langkah-langkah pengendalian secara sistematis dan konsisten. Terdapat lima tahapan utama yang harus dilakukan dalam proses pengendalian pelayanan keperawatan (E. J. Sullivan, 2018):

1. Menetapkan kriteria atau standar kinerja yang jelas dan terukur

Langkah awal yang krusial adalah penetapan standar atau kriteria kinerja perawat yang bersifat spesifik, terukur, relevan, dan dapat dipahami oleh seluruh anggota tim keperawatan. Manajer keperawatan perlu menyusun indikator kinerja yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan budaya organisasi tempat mereka bekerja. Standar tersebut kemudian harus disosialisasikan secara menyeluruh dan dikomunikasikan secara terbuka kepada seluruh perawat, sehingga tidak menimbulkan ambiguitas atau perbedaan persepsi dalam pelaksanaan tugas. Setiap rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan dapat memiliki standar kerja yang berbeda, penting bagi manajer untuk melakukan penyesuaian dengan visi, misi, dan tujuan organisasi yang bersangkutan.

2. Mengidentifikasi informasi yang relevan dengan standar kinerja

Langkah selanjutnya yaitu mengenali dan mengidentifikasi berbagai data dan informasi yang berkaitan langsung dengan standar tersebut. Perawat harus memahami bagaimana tugas-tugas mereka akan dinilai berdasarkan kriteria yang telah disusun, serta mampu menyesuaikan aktivitas keperawatan yang mereka lakukan agar selaras dengan standar tersebut, misalnya setelah pasien menjalani tindakan pembedahan dan berada di ruang pemulihan pascaoperasi, perawat diharapkan untuk segera melakukan pengukuran tanda-tanda vital, mengevaluasi kondisi balutan luka, serta melakukan pemeriksaan neurologis. Aktivitas tersebut merupakan indikator yang dapat digunakan untuk menilai kepatuhan dan kualitas tindakan keperawatan yang diberikan.

3. Menentukan metode pengumpulan informasi yang efektif

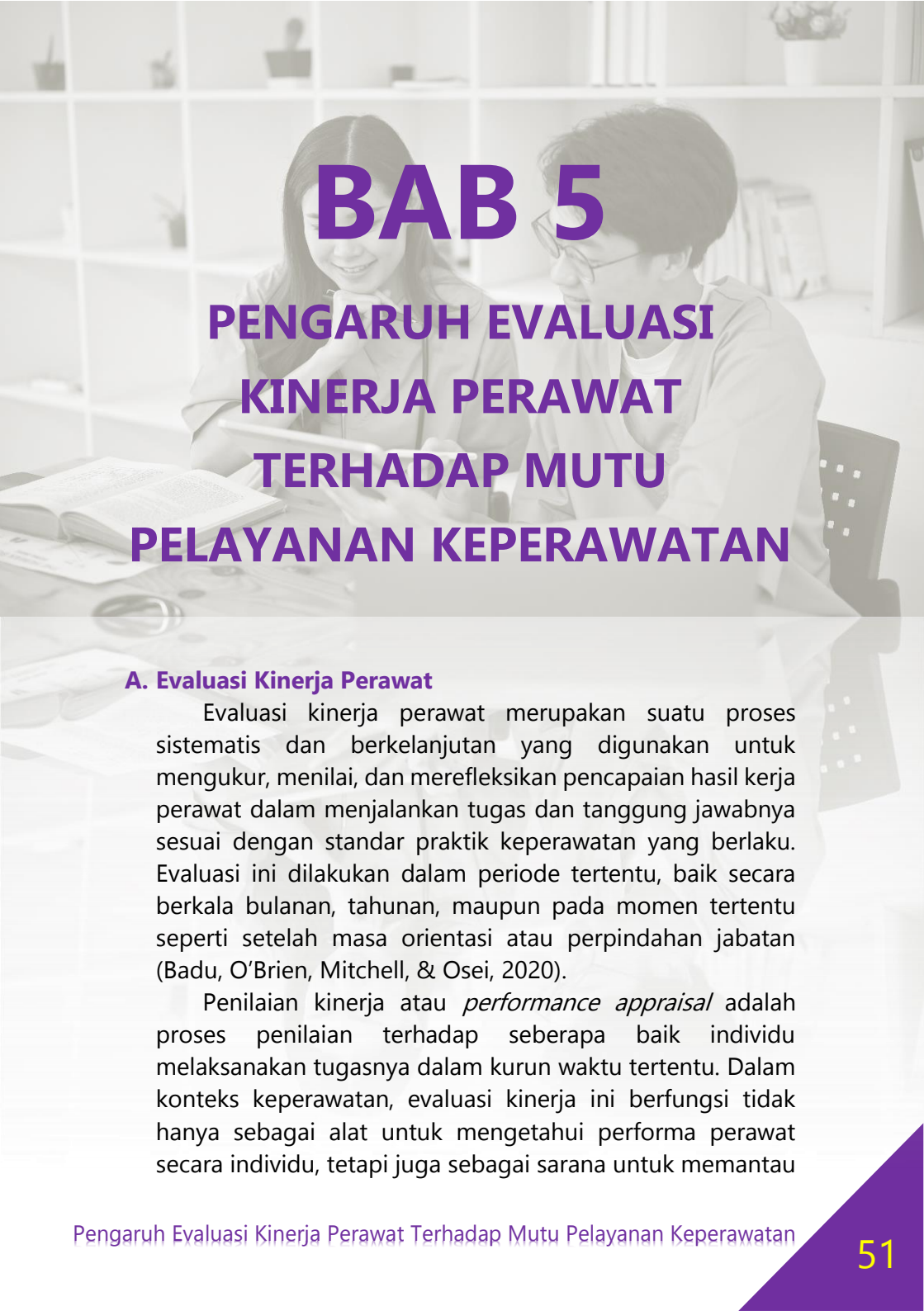
Manajer keperawatan harus memastikan bahwa semua data yang dikumpulkan untuk menilai kinerja staf berasal dari sumber yang valid, andal, dan tepat guna. Pengumpulan informasi bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti observasi langsung, audit dokumentasi keperawatan, wawancara, kuesioner, laporan insiden, serta instrumen penilaian lainnya. Penting bagi manajer untuk memilih metode yang paling sesuai agar data yang diperoleh dapat mencerminkan kinerja nyata di lapangan.

4. Melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan

Setelah informasi dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut untuk mengevaluasi apakah kinerja perawat sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Manajer keperawatan menggunakan alat ukur atau instrumen evaluasi yang telah disepakati sebelumnya untuk melakukan penilaian secara objektif. Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa perawat telah memenuhi atau bahkan melampaui standar, maka manajer dapat memberikan penghargaan sebagai bentuk motivasi dan sebaliknya apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian atau kekurangan dalam kinerja perawat, maka diperlukan peninjauan ulang terhadap proses kerja, dan jika perlu, kriteria penilaian juga dapat disesuaikan.

5. Melaksanakan evaluasi ulang dan analisis masalah secara mendalam

Tahapan terakhir adalah melakukan evaluasi kembali terhadap kinerja perawat yang secara konsisten belum mencapai target yang ditentukan. Evaluasi ini tidak hanya bersifat menilai, tetapi juga menggali penyebab mendasar dari terjadinya penurunan kinerja. Faktor-faktor seperti beban kerja yang terlalu tinggi, kurangnya pelatihan, komunikasi yang tidak efektif, atau bahkan kurangnya motivasi perlu ditelusuri lebih lanjut. Hasil analisis ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk menyusun intervensi perbaikan yang lebih tepat sasaran, baik melalui pelatihan ulang, supervisi lebih intensif, maupun revisi terhadap standar yang dinilai tidak realistis.



BAB 5

PENGARUH EVALUASI KINERJA PERAWAT TERHADAP MUTU PELAYANAN KEPERAWATAN

A. Evaluasi Kinerja Perawat

Evaluasi kinerja perawat merupakan suatu proses sistematis dan berkelanjutan yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan merefleksikan pencapaian hasil kerja perawat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar praktik keperawatan yang berlaku. Evaluasi ini dilakukan dalam periode tertentu, baik secara berkala bulanan, tahunan, maupun pada momen tertentu seperti setelah masa orientasi atau perpindahan jabatan (Badu, O'Brien, Mitchell, & Osei, 2020).

Penilaian kinerja atau *performance appraisal* adalah proses penilaian terhadap seberapa baik individu melaksanakan tugasnya dalam kurun waktu tertentu. Dalam konteks keperawatan, evaluasi kinerja ini berfungsi tidak hanya sebagai alat untuk mengetahui performa perawat secara individu, tetapi juga sebagai sarana untuk memantau

kebutuhan peningkatan kompetensi, mendorong pengembangan profesional, memperbaiki mutu layanan, serta menjamin pencapaian tujuan pelayanan keperawatan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada keselamatan pasien (Akdemir, Peterson, Campbell, & Scheele, 2020).

Evaluasi kinerja mencerminkan interaksi antara dua komponen utama, yaitu kemampuan dan motivasi perawat. Kemampuan mencakup pengetahuan, keterampilan teknis, serta sikap profesional dalam melaksanakan tugas keperawatan, sedangkan motivasi meliputi dorongan internal yang mempengaruhi semangat kerja, komitmen, dan loyalitas perawat dalam memberikan pelayanan yang optimal. Tugas tidak akan terselesaikan secara efektif tanpa adanya kemauan dan dorongan dari dalam diri individu. Peran pemimpin atau manajer keperawatan menjadi sangat penting dalam proses evaluasi ini, tidak hanya sebagai penilai tetapi juga sebagai motivator dan fasilitator pengembangan staf (Murray, 2017).

Pemimpin keperawatan yang efektif tidak hanya mampu memberikan umpan balik secara konstruktif berdasarkan hasil evaluasi, tetapi juga mampu mendorong perawat untuk meningkatkan kinerja melalui motivasi, coaching, pelatihan, dan pemberdayaan. Evaluasi kinerja perawat yang dilakukan secara adil, transparan, dan objektif akan menjadi landasan penting dalam menciptakan budaya kerja yang profesional, menumbuhkan akuntabilitas, serta meningkatkan mutu pelayanan keperawatan secara keseluruhan (Huber, 2018).

B. Periode Evaluasi Kinerja Perawat

Penilaian dan evaluasi kinerja perawat merupakan proses penting dalam menjamin mutu pelayanan keperawatan yang berkelanjutan. Agar pelaksanaannya efektif, kegiatan evaluasi harus dilakukan secara sistematis

dan terjadwal sesuai dengan tahapan-tahapan penting dalam perjalanan profesi seorang perawat di unit pelayanan. Berdasarkan Panduan Penilaian Praktik Keperawatan Profesional Berkelanjutan bahwa terdapat empat periode utama evaluasi yang harus dilaksanakan oleh manajer atau supervisor keperawatan (Huber, 2018):

1. Evaluasi setelah masa orientasi

Evaluasi setelah masa orientasi merupakan tahapan penting dalam proses pembinaan dan penjaminan mutu tenaga keperawatan, khususnya bagi perawat baru yang ditempatkan di unit kerja tertentu. Evaluasi ini biasanya dilakukan dalam jangka waktu satu hingga tiga bulan setelah perawat menyelesaikan masa orientasi awal, dengan tujuan utama untuk menilai sejauh mana perawat memahami dan mampu mengimplementasikan standar pelayanan, nilai-nilai organisasi, prosedur kerja, serta etika profesi di lingkungan kerjanya. Manajemen keperawatan dapat menilai tingkat kesiapan perawat dalam bekerja secara mandiri, mengidentifikasi kebutuhan penguatan kompetensi, serta menilai kecocokan penempatan berdasarkan minat dan kemampuan perawat. Evaluasi ini juga menjadi sarana memberikan umpan balik yang konstruktif kepada perawat baru, baik dalam bentuk penguatan positif maupun saran perbaikan agar mereka dapat berkembang secara profesional. Evaluasi ini mencakup berbagai aspek seperti pengetahuan dan keterampilan klinis, kemampuan komunikasi dengan pasien dan tim, kepatuhan terhadap standar keselamatan pasien, serta ketepatan dalam dokumentasi keperawatan. Proses evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti observasi langsung, checklist kinerja, diskusi evaluatif,

hingga refleksi diri, dan hasil evaluasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk menentukan kelanjutan pembinaan, seperti pemberian pelatihan tambahan, pendampingan, atau bahkan perencanaan pengembangan individu. Rumah sakit dengan pelaksanaan evaluasi yang terstruktur dan sistematis dapat memastikan bahwa setiap perawat baru siap memberikan pelayanan yang aman, kompeten, dan sesuai standar, sekaligus meningkatkan retensi dan kepuasan kerja perawat dalam jangka panjang.

2. Evaluasi Setelah Penempatan Definitif

Evaluasi setelah penempatan definitif merupakan lanjutan dari proses pembinaan dan pemantauan kinerja perawat yang dilakukan sekitar satu bulan setelah perawat secara resmi menempati posisi tetap di unit kerja tertentu. Evaluasi ini tidak hanya berlaku bagi perawat baru, tetapi juga sangat penting bagi perawat yang mengalami alih tugas atau mutasi internal antar unit. Tujuan utama dari evaluasi ini adalah untuk menilai sejauh mana perawat dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru, baik dari segi fisik, sosial, maupun profesional. Hal ini mencakup kemampuan perawat dalam memahami alur pelayanan di unit baru, menjalin komunikasi dan kerja sama dengan tim, serta menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai standar yang berlaku.

Evaluasi ini juga memberikan gambaran awal tentang tingkat pemahaman perawat terhadap kebijakan dan prosedur unit, penerapan praktik keperawatan berbasis bukti, dan keterlibatan dalam aktivitas peningkatan mutu layanan. Proses ini berfungsi untuk mengidentifikasi potensi, kekuatan, serta area yang masih perlu diperbaiki

atau dikembangkan dari masing-masing individu. Rumah sakit dapat menyusun strategi pengembangan personal yang lebih tepat sasaran, misalnya melalui pelatihan lanjutan, pendampingan oleh perawat senior, atau rotasi tugas yang bertujuan memperluas wawasan klinis perawat.

Evaluasi ini juga menjadi kesempatan untuk memastikan bahwa penempatan yang telah dilakukan sudah sesuai dengan kompetensi dan minat perawat, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Evaluasi ini biasanya dilakukan melalui kombinasi metode seperti supervisi langsung, pengisian instrumen evaluasi kinerja, wawancara, dan review dokumentasi pelayanan. Pelaksanaan evaluasi yang menyeluruh dan berkelanjutan setelah penempatan definitif diharapkan kinerja perawat dapat terus meningkat dan pelayanan yang diberikan kepada pasien menjadi lebih efektif, aman, dan bermutu tinggi.

3. Evaluasi Bulanan

Evaluasi bulanan merupakan salah satu bentuk kegiatan manajerial yang strategis dalam menjaga dan meningkatkan kinerja perawat secara konsisten. Evaluasi ini dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan pembinaan berkelanjutan, yang tidak hanya menekankan pada aspek penilaian kinerja, tetapi juga pada upaya pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia keperawatan. Evaluasi bulanan disesuaikan dengan isi kontrak kerja dan tanggung jawab masing-masing perawat, sehingga penilaiannya bersifat individual dan kontekstual sesuai dengan beban kerja dan lingkup tugas di unit masing-masing.

Fokus dari evaluasi ini mencakup berbagai aspek, antara lain kompetensi teknis keperawatan seperti keterampilan klinis dalam tindakan keperawatan, kemampuan melakukan observasi pasien, pengambilan keputusan klinis, serta ketepatan dalam melaksanakan prosedur standar operasional. Kemampuan komunikasi terapeutik juga menjadi poin penting, terutama dalam interaksi dengan pasien, keluarga, serta antarprofesi di lingkungan kerja. Evaluasi juga mencakup kualitas dokumentasi asuhan keperawatan, kepatuhan terhadap kebijakan rumah sakit, kedisiplinan, tanggung jawab, serta sikap kerja profesional lainnya seperti empati, kerja tim, dan etika.

Evaluasi bulanan bersifat korektif dan preventif, artinya tidak hanya dimaksudkan untuk mengidentifikasi kekurangan atau pelanggaran, tetapi juga untuk mencegah munculnya masalah yang lebih besar di kemudian hari. Jika ditemukan adanya penurunan performa, kelalaian, atau ketidaksesuaian perilaku kerja, maka manajer keperawatan dapat segera melakukan intervensi berupa pembinaan, pendampingan, atau konseling. Bila ada peningkatan kinerja atau pencapaian tertentu, evaluasi ini juga menjadi sarana untuk memberikan penghargaan atau penguatan positif guna meningkatkan motivasi kerja. Proses evaluasi dapat dilakukan melalui observasi langsung, penilaian kepala ruang, refleksi diri perawat, analisis laporan keperawatan, hingga feedback dari pasien dan rekan sejawat.

Rumah sakit dengan melakukan evaluasi secara berkala setiap bulan dapat membangun sistem mutu yang berkelanjutan serta menciptakan budaya kerja yang profesional, disiplin, dan responsif terhadap perubahan

dan tuntutan pelayanan kesehatan. Evaluasi ini juga menjadi landasan dalam proses perencanaan pengembangan karier, pelatihan berkelanjutan, dan promosi jabatan yang berbasis pada data kinerja nyata.

4. Evaluasi Tahunan

Evaluasi tahunan merupakan bentuk penilaian kinerja yang bersifat komprehensif dan strategis, dilaksanakan pada akhir tahun sebagai puncak dari seluruh rangkaian evaluasi yang telah dilakukan secara periodik selama satu tahun berjalan. Evaluasi ini tidak hanya berfokus pada hasil kerja perawat dalam kurun waktu satu tahun, tetapi juga pada proses, konsistensi, dan perkembangan yang ditunjukkan oleh masing-masing individu. Tujuan utamanya adalah untuk menilai sejauh mana capaian kompetensi perawat sesuai dengan standar yang ditetapkan, realisasi target kerja individu dan unit, serta kontribusi nyata terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis organisasi rumah sakit.

Ruang lingkup evaluasi tahunan mencakup berbagai aspek, mulai dari kompetensi teknis keperawatan, soft skills seperti komunikasi dan kolaborasi tim, kedisiplinan kerja, kepemimpinan (bila relevan), hingga integritas profesional dalam menjalankan tugas sehari-hari. Evaluasi ini juga mencerminkan integrasi dari semua proses pembinaan dan penilaian yang telah dilakukan sebelumnya, seperti evaluasi pasca orientasi, evaluasi setelah penempatan definitif, serta evaluasi bulanan. Evaluasi tahunan bukan hanya bersifat administratif, melainkan merupakan potret utuh kinerja dan perkembangan perawat sepanjang tahun.

Metode evaluasi tahunan biasanya melibatkan

instrumen yang lebih formal dan terstandar, seperti formulir penilaian kinerja tahunan, wawancara langsung dengan atasan atau kepala ruangan, analisis rekam jejak kinerja dan disiplin, hingga hasil umpan balik dari pasien, rekan sejawat, dan tenaga kesehatan lintas profesi. Evaluasi ini juga melibatkan sistem penilaian berbasis kompetensi atau bahkan pendekatan 360 derajat untuk memperoleh gambaran penilaian yang lebih objektif dan holistik.

Hasil dari evaluasi tahunan memiliki implikasi penting dalam pengambilan keputusan manajerial terkait tenaga keperawatan. Evaluasi ini dijadikan dasar dalam memperpanjang atau mengakhiri kontrak kerja, mempertimbangkan promosi jabatan struktural atau fungsional, pemberian insentif dan penghargaan kinerja, serta dalam menyusun rencana pengembangan sumber daya manusia untuk tahun berikutnya. Perawat yang menunjukkan kinerja unggul dapat direkomendasikan untuk mengikuti pelatihan lanjutan, mendapatkan tugas khusus, atau dilibatkan dalam program kepemimpinan keperawatan. Perawat yang menunjukkan kinerja kurang memuaskan akan dibina lebih lanjut atau mendapatkan rekomendasi penguatan kompetensi melalui pelatihan atau supervisi tambahan.

Organisasi dengan evaluasi tahunan yang objektif, transparan, dan konstruktif, tidak hanya dapat menjaga kualitas layanan keperawatan tetapi juga membangun budaya kerja yang profesional dan berbasis kinerja. Evaluasi ini juga mendorong terciptanya sistem pembinaan karier yang adil, terencana, dan mendukung retensi tenaga keperawatan berkualitas di lingkungan rumah sakit.

C. Pengaruh Evaluasi Berkala Kinerja Perawat Terhadap Mutu Pelayanan Keperawatan

Mutu pelayanan keperawatan merupakan aspek fundamental dalam sistem pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kualitas asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien tidak hanya mencerminkan profesionalisme perawat, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap keselamatan pasien, kepuasan klien, dan efektivitas sistem pelayanan secara keseluruhan. Berbagai strategi telah dikembangkan sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan tersebut, salah satunya adalah dengan melaksanakan evaluasi kinerja perawat secara berkala.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di RSUD Kabupaten Raja Ampat dengan melibatkan 108 perawat sebagai responden penelitian menunjukkan bahwa pengukuran skor mutu pelayanan keperawatan memiliki nilai minimal sebesar 63 dan maksimal 97 (skor tertinggi 105) dengan nilai median yang diperoleh adalah 72. Skor minimum yang tergolong rendah ini mengindikasikan adanya persepsi negatif dari sebagian perawat terhadap kualitas pelayanan yang mereka berikan sebelum adanya evaluasi sistematis. Hal ini konsisten dengan temuan dari Yusefi et al tahun 2022 yang menyatakan bahwa sebagian besar mutu pelayanan keperawatan masih berada pada kategori sedang (64,11%) dan hanya sebagian kecil yang berada dalam kategori baik (19,49%).

Setelah intervensi berupa pelaksanaan evaluasi kinerja berkala selama tiga bulan, terjadi perubahan yang cukup signifikan yaitu skor mutu pelayanan keperawatan dengan nilai minimum 67, maksimum 101, median 77. Analisa statistik menggunakan uji Wilcoxon juga menunjukkan bahwa sebanyak 93 perawat menunjukkan peningkatan skor

mutu pelayanan, sementara 15 responden mengalami stagnasi, dan tidak ada responden yang mengalami penurunan kinerja. Hasil uji statistik Wilcoxon Signed Rank Test menunjukkan nilai signifikansi (P) sebesar 0,000, yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara mutu pelayanan keperawatan sebelum dan sesudah intervensi, sehingga evaluasi kinerja secara berkala terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan di rumah sakit.

Penemuan ini juga diperkuat oleh penelitian lain yang dilakukan oleh Hidayati, Makhrus, & Tjitra tahun 2021 yang menyatakan bahwa penilaian kinerja yang dilakukan secara konsisten oleh kepala ruangan mampu meningkatkan mutu kerja perawat, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada peningkatan kualitas asuhan keperawatan kepada pasien. Penting untuk dipahami bahwa mutu pelayanan keperawatan tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan teknis atau keterampilan klinis perawat. Pelayanan yang bermutu juga sangat bergantung pada faktor non-teknis seperti sikap profesional, etika, kemampuan komunikasi, empati, dan integritas dalam menjalankan praktik keperawatan.

Stavropoulou et al tahun 2022 juga menerangkan bahwa kompetensi teknis memang penting untuk menjamin keamanan dan ketepatan tindakan, namun kualitas pelayanan yang tinggi menuntut adanya pendekatan holistik yang mengedepankan interaksi yang manusiawi, sabar, dan penuh rasa hormat terhadap pasien. Hubungan terapeutik yang terjalin antara perawat dan pasien sangat dipengaruhi oleh keterampilan komunikasi yang baik serta kemampuan perawat dalam memahami kondisi emosional pasien secara mendalam (Alikari et al., 2022).

Evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala memberikan ruang reflektif bagi perawat untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Dalam jangka waktu tiga bulan, perawat memiliki kesempatan untuk meninjau kembali praktik keperawatannya, menerima umpan balik yang konstruktif, dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Pendekatan ini secara tidak langsung menumbuhkan budaya kerja yang lebih profesional, bertanggung jawab, dan terukur. Sistem evaluasi yang baik mendorong terciptanya lingkungan kerja yang mendukung perbaikan berkelanjutan, memperkuat akuntabilitas, serta menciptakan standar kerja yang jelas dan konsisten (Garay, Haeger, Kühnlein, Sulmann, & Suhr, 2023).

Evaluasi berkala juga membuka jalur komunikasi dua arah yang sehat antara perawat dan manajemen. Ketika penilaian dilakukan secara terbuka, obyektif, dan berdasarkan instrumen yang valid, maka akan tercipta rasa kepercayaan dan keterbukaan dalam tim. Hubungan profesional antara perawat dan atasan yang dibangun melalui evaluasi yang sistematis mampu meningkatkan semangat kerja, menurunkan resistensi terhadap perubahan, dan memperkuat loyalitas terhadap organisasi (Yang, 2022).

Dampak positif dari peningkatan mutu pelayanan keperawatan tidak hanya dirasakan oleh perawat secara individu, tetapi juga berdampak pada organisasi secara keseluruhan. Peningkatan mutu ini dapat meningkatkan kepuasan pasien, mempercepat proses penyembuhan, mengurangi angka kesalahan tindakan, serta meningkatkan efisiensi pelayanan. Sistem evaluasi yang berkelanjutan merupakan komponen esensial dalam menciptakan pelayanan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pasien yang terus berkembang (Qtait, 2023).

Pelaksanaan evaluasi kinerja setiap tiga bulan memberi peluang bagi pimpinan unit atau kepala ruangan untuk melakukan intervensi dini apabila ditemukan adanya penurunan kinerja. Intervensi ini dapat berbentuk pelatihan lanjutan, supervisi langsung, pembinaan etika profesi, atau pendampingan dalam menghadapi kasus-kasus sulit. Evaluasi tidak hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga menjadi sarana pembinaan dan pengembangan profesionalisme perawat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Data hasil evaluasi kinerja juga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan penting di tingkat manajerial, seperti promosi jabatan, rotasi tugas, hingga penetapan kebutuhan pelatihan keperawatan yang berbasis kebutuhan nyata di lapangan, sehingga sistem evaluasi kinerja yang terstruktur dan konsisten sangat penting untuk diterapkan sebagai bagian dari strategi peningkatan mutu pelayanan keperawatan dalam jangka panjang.

BAB 6

PENUTUP

Evaluasi kinerja perawat yang dilakukan secara berkala tidak hanya merupakan prosedur administratif rutin, melainkan merupakan komponen penting dalam sistem manajemen mutu pelayanan keperawatan. Evaluasi ini menjadi mekanisme formal yang memungkinkan organisasi layanan kesehatan untuk menilai, menyesuaikan, dan meningkatkan kualitas asuhan keperawatan melalui pemantauan yang objektif dan sistematis terhadap kinerja perawat. Mutu dan keselamatan pasien menjadi indikator utama keberhasilan institusi, evaluasi berkala berfungsi sebagai jembatan antara harapan manajerial dan realitas klinis di lapangan.

Manajer keperawatan dapat menilai sejauh mana praktik keperawatan telah sesuai dengan standar kompetensi profesional, pedoman praktik, serta prosedur operasional yang berlaku melalui proses evaluasi yang konsisten. Evaluasi ini bukan hanya mengungkapkan kelemahan dan kesenjangan dalam pelaksanaan tugas, tetapi juga menyoroti kekuatan dan potensi pengembangan diri dari masing-masing perawat. Evaluasi menjadi alat refleksi dan perbaikan diri secara berkelanjutan, bukan sebagai mekanisme kontrol yang represif. Evaluasi kinerja yang dirancang secara tepat dapat menjadi sumber motivasi intrinsik bagi perawat untuk meningkatkan

profesionalisme, etika kerja, dan kualitas pelayanan yang mereka berikan kepada pasien.

Hasil penelitian yang telah dibahas dalam buku ini secara nyata menunjukkan bahwa evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala dengan instrumen yang sah dan prosedur yang transparan, memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pelayanan keperawatan. Pelayanan menjadi lebih responsif, komunikatif, serta terstandarisasi, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kepuasan pasien dan keluarganya. Evaluasi yang dilakukan secara objektif dan partisipatif juga mampu membangun budaya organisasi yang sehat, dimana setiap anggota tim merasa dihargai, didengar, dan diajak untuk bertumbuh bersama.

Evaluasi berkala juga berperan penting dalam membangun akuntabilitas dan transparansi dalam praktik keperawatan. Ketika perawat mengetahui bahwa kinerja mereka akan dinilai secara periodik berdasarkan indikator yang jelas, hal ini akan mendorong peningkatan kesadaran profesional, kepatuhan terhadap protokol keselamatan pasien, serta ketekunan dalam mendokumentasikan asuhan secara akurat. Evaluasi membuka ruang dialog yang konstruktif antara staf dan manajer keperawatan, menciptakan kesempatan untuk memberikan umpan balik, menyusun rencana perbaikan, serta menetapkan target kinerja yang lebih terarah dan terukur.

Dampak evaluasi berkala juga dapat dirasakan dalam aspek manajemen sumber daya manusia. Data hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar dalam proses rekrutmen internal, rotasi staf, pengembangan jenjang karier, hingga pengambilan keputusan strategis dalam perencanaan pelatihan dan pendidikan lanjutan. Institusi pelayanan kesehatan yang secara konsisten melakukan evaluasi kinerja akan memiliki basis data yang kuat untuk mendukung proses peningkatan mutu

berkelanjutan (continuous quality improvement), termasuk dalam memenuhi standar akreditasi nasional maupun internasional.

Evaluasi berkala juga memainkan peran dalam mengidentifikasi kebutuhan dukungan struktural dan sistemik, seperti kebutuhan terhadap pelatihan tambahan, penyesuaian beban kerja, maupun pembaruan kebijakan organisasi. Evaluasi menjadi indikator awal atas potensi masalah yang mungkin timbul, baik dalam aspek keterampilan individu maupun dalam efisiensi sistem kerja secara keseluruhan. Praktik evaluasi berkala yang dijalankan secara menyeluruh akan membentuk sistem pelayanan keperawatan yang tangguh, adaptif, dan berorientasi pada pembelajaran berkelanjutan.

Efektivitas evaluasi berkala sangat ditentukan oleh kualitas pelaksanaannya. Evaluasi yang hanya bersifat formalitas atau sekadar pengisian formulir rutin tanpa analisis dan tindak lanjut yang jelas, tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap mutu pelayanan, sehingga dibutuhkan komitmen organisasi untuk menyediakan sumber daya yang memadai, pelatihan bagi evaluator, serta sistem pelaporan dan umpan balik yang efektif. Evaluasi harus bersifat dinamis, berbasis data, dan dilakukan dalam suasana yang suportif dan saling menghargai.

Budaya evaluasi berkala harus menjadi bagian integral dari sistem manajemen mutu rumah sakit sebagai upaya dalam menghadapi tantangan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks dan dinamis. Proses ini perlu diintegrasikan ke dalam sistem informasi manajemen keperawatan, dikaitkan dengan indikator kinerja utama (Key Performance Indicators), serta dilaporkan secara periodik kepada tim manajemen. Evaluasi juga harus menyentuh aspek soft skill seperti empati, komunikasi interpersonal, dan kemampuan kerja sama tim, yang semuanya merupakan bagian penting dari mutu asuhan

keperawatan.

Keberhasilan evaluasi berkala dalam meningkatkan mutu pelayanan keperawatan tidak hanya bergantung pada apa yang dievaluasi, tetapi juga bagaimana proses evaluasi itu dilaksanakan, ditindaklanjuti, dan dimaknai oleh seluruh pihak yang terlibat. Evaluasi kinerja bukan sekadar laporan statistik, melainkan cerminan dari budaya organisasi yang berorientasi pada profesionalisme, akuntabilitas, dan pelayanan yang manusiawi.

Penulis merekomendasikan agar evaluasi berkala kinerja perawat dijadikan sebagai instrumen strategis dalam perencanaan mutu, dengan dukungan kebijakan, struktur organisasi yang jelas, serta sistem reward and punishment yang adil. Evaluasi harus menjadi bagian dari siklus pengembangan SDM yang berkesinambungan, bukan kegiatan yang berdiri sendiri. Hanya dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, mutu pelayanan keperawatan dapat terus dijaga dan ditingkatkan, demi keselamatan dan kepuasan pasien serta kemajuan institusi pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA



- Afriliana, L., Suryawati, C., & Dwiantoro, L. (2023). EFFECT OF NURSE CARING BEHAVIOR AND COMMUNICATION ON INPATIENTS SATISFACTION. *International Journal of Artificial Intelligence Research*, 6(1.1). <https://doi.org/10.29099/ijair.v6i1.1.513>
- Ahmed, R. A., Wong, A. H., Musits, A. N., Cardell, A., Cassara, M., Wong, N. L., ... Szyld, D. (2022). Accreditation of Simulation Fellowships and Training Programs: More Checkboxes or Elevating the Field? *Simulation in Healthcare: Journal of the Society for Simulation in Healthcare*, 17(2), 120–130. <https://doi.org/10.1097/SIH.0000000000000593>
- Aini, N. (2018). *Teori model keperawatan*. Malang: UMM Press.
- Akdemir, N., Peterson, L. N., Campbell, C. M., & Scheele, F. (2020). Evaluation of continuous quality improvement in accreditation for medical education. *BMC Medical Education*, 20(Suppl 1), 308. <https://doi.org/10.1186/s12909-020-02124-2>
- Alikari, V., Gerogianni, G., Fradelos, E. C., Kelesi, M., Kaba, E., & Zyga, S. (2022). Perceptions of Caring Behaviors among Patients and Nurses. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(1), 396. <https://doi.org/10.3390/ijerph20010396>
- Alloubani, A., Akhu-Zaheya, L., Abdelhafiz, I. M., & Almatari, M. (2019). Leadership styles' influence on the quality of nursing care. *International Journal of Health Care Quality Assurance*, 32(6), 1022–1033. <https://doi.org/10.1108/IJHCQA-06-2018-0138>

- Alsadaan, N., Salameh, B., Reshia, F. A. A. E., Alruwaili, R. F., Alruwaili, M., Awad Ali, S. A., ... Jones, L. K. (2023). Impact of Nurse Leaders Behaviors on Nursing Staff Performance: A Systematic Review of Literature. *INQUIRY: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing*, 60, 004695802311785. <https://doi.org/10.1177/00469580231178528>
- Badu, E., O'Brien, A. P., Mitchell, R., & Osei, A. (2020). *A realistic evaluation of evidence-based therapeutic processes in mental health services– Context-Mechanisms-Outcomes* [Preprint]. In Review. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-81487/v1>
- Baumann, A., & Crea-Arsenio, M. (2023). The Crisis in the Nursing Labour Market: Canadian Policy Perspectives. *Healthcare*, 11(13), 1954. <https://doi.org/10.3390/healthcare11131954>
- Bramlett, C. (2018). *Servant leadership roadmap: Master the 12 core competencies of management success with leadership qualities and interpersonal skills*. San Bernardino, CA: Create Space.
- Cristina, M., Nogueira, P., Oliveira, M. M., & Santos, C. (2024). Project management in healthcare: An examination of organizational competence. *Heliyon*, 10(15), e35419. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e35419>
- Dahlkemper, T. R. (2021). *Nursing leadership, management, and professional practice for the LPN/LVN* (Seventh edition). Philadelphia: F. A. Davis.
- Garay, S., Haeger, M., Kühnlein, L., Sulmann, D., & Suhr, R. (2023). Interventions to enhance safety culture for nursing professionals in long-term care: A systematic review.

International Journal of Nursing Studies Advances, 5, 100119. <https://doi.org/10.1016/j.ijnsa.2023.100119>

- Ghofrani, M., Valizadeh, L., Zamanzadeh, V., Ghahramanian, A., Janati, A., & Taleghani, F. (2024). Adapting the Donabedian model in undergraduate nursing education: A modified Delphi study. *BMC Medical Education*, 24(1), 202. <https://doi.org/10.1186/s12909-024-05187-7>
- Hidaya, N., Alfianur, A., & Handayani, F. (2020). *Manajemen dan kepemimpinan dalam keperawatan*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Hidayati, T., Makhrus, I., & Tjitra, E. (2021). Pengaruh Pengembangan Penilaian Kinerja Perawat Rawat Inap oleh Kepala Ruang Terhadap Pencapaian Standar Kinerja Perawat di Rumah Sakit Sumber Waras. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 12(3).
- Huber, D. L. (Ed.). (2018). *Leadership & nursing care management* (Sixth edition). St. Louis: Elsevier.
- Leso, B. H., Cortimiglia, M. N., & Ghezzi, A. (2023). The contribution of organizational culture, structure, and leadership factors in the digital transformation of SMEs: A mixed-methods approach. *Cognition, Technology & Work (Online)*, 25(1), 151–179. <https://doi.org/10.1007/s10111-022-00714-2>
- Malekzadeh, R., Abedi, G., Hasanpoor, E., & Ghasemi, M. (2021). A Hospital Performance Assessment Model Using the IPOCC Approach. *Ethiopian Journal of Health Sciences*, 31(3), 533–542. <https://doi.org/10.4314/ejhs.v31i3.10>
- Molina-Mula, J., & Gallo-Estrada, J. (2020). Impact of Nurse-Patient Relationship on Quality of Care and Patient

Autonomy in Decision-Making. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(3), 835. <https://doi.org/10.3390/ijerph17030835>

- Mrayyan, M. T., Abunab, H. Y., Abu Khait, A., Rababa, M. J., Al-Rawashdeh, S., Aljunmeeyn, A., & Abu Saraya, A. (2023). Competency in nursing practice: A concept analysis. *BMJ Open*, 13(6), e067352. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-067352>
- Murray, E. J. (2017). *Nursing leadership and management for patient safety and quality care*. Philadelphia: F.A. Davis Company.
- Ofei, A. M. A., Poku, C. A., Paarima, Y., Barnes, T., & Kwashie, A. A. (2023). Toxic leadership behaviour of nurse managers and turnover intentions: The mediating role of job satisfaction. *BMC Nursing*, 22(1), 374. <https://doi.org/10.1186/s12912-023-01539-8>
- Oluma, A., & Abadiga, M. (2020). Caring behavior and associated factors among nurses working in Jimma University specialized hospital, Oromia, Southwest Ethiopia, 2019. *BMC Nursing*, 19(1), 19. <https://doi.org/10.1186/s12912-020-0407-2>
- Ortega, L. R., Barrado-Narvi3n, M. J., & Bernu3s-Oliv3n, J. (2023). Acquisition of Competencies of Nurses: Improving the Performance of the Healthcare System. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(5), 4510. <https://doi.org/10.3390/ijerph20054510>
- Pitk3nen, V., & Linnosmaa, I. (2021). Choice, quality and patients' experience: Evidence from a Finnish physiotherapy service. *International Journal of Health Economics and*

- Management*, 21(2), 229–245.
<https://doi.org/10.1007/s10754-020-09293-z>
- Porter, O. T., Weberg, D. R., Mangold, K., & Malloch, K. (2019). *Leadership in nursing practice: Changing the landscape of health care* (Third). Burlington, Massachusetts: Jones & Bartlett Learning.
- Qtait, M. (2023). Systematic Review of Head Nurse Leadership Style and Nurse Performance. *International Journal of Africa Nursing Sciences*, 18, 100564.
<https://doi.org/10.1016/j.ijans.2023.100564>
- Stavropoulou, A., Rovithis, M., Kelesi, M., Vasilopoulos, G., Sigala, E., Papageorgiou, D., ... Koukouli, S. (2022). What Quality of Care Means? Exploring Clinical Nurses' Perceptions on the Concept of Quality Care: A Qualitative Study. *Clinics and Practice*, 12(4), 468–481.
<https://doi.org/10.3390/clinpract12040051>
- Sullivan, E. J. (2018). *Effective leadership and management in nursing* (Ninth edition). New York, NY: Pearson.
- Sullivan, M., & Hyland Robertson, L. C. (2020). *Understanding yoga therapy: Applied philosophy and science for health and well-being*. New York: Routledge.
- Yang, G. (2022). The construction of nursing performance evaluation model in community health service center based on the balanced scorecard and hygiene factors. *Scientific Reports*, 12(1).
<https://doi.org/10.1038/s41598-022-26334-4>
- Yusefi, A. R., Sarvestani, S. R., Kavosi, Z., Bahmaei, J., Mehrizi, M. M., & Mehralian, G. (2022). Patients' perceptions of the quality of nursing services. *BMC Nursing*, 21(1), 131.
<https://doi.org/10.1186/s12912-022-00906-1>

PROFIL PENULIS



Nur Samti Rumadaul, S.Kep., Ns., adalah perawat ASN yang bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat pada Unit Pelaksana Teknis RSUD Raja Ampat. Penulis pertama kali ditugaskan sebagai perawat di RS Lapangan Marinda pada tahun 2011. Sejak tahun 2013 hingga 2024, ia mengabdikan sebagai perawat di Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Raja Ampat, dan saat ini bertugas sebagai staf di unit pelayanan dan penunjang medik rumah sakit tersebut. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Keperawatan pada tahun 2009 dan melanjutkan pendidikan profesi Ners pada tahun 2010 di STIKES Kendal. Lahir di Kalobo pada 29 Maret 1988, penulis aktif sebagai tenaga kesehatan haji dan berperan dalam organisasi profesi perawat, yakni sebagai Sekretaris DPD PPNI Kabupaten Raja Ampat. Selain itu, penulis juga terdaftar dan aktif sebagai Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK).

DAFTAR PUSTAKA



Dr. Blacius Dedi, SKM., M.Kep.,

merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat. Pendidikan dasar diselesaikan di SDN Cijoho, Tasikmalaya, kemudian melanjutkan ke jenjang SLTP di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Setelah itu, penulis menempuh pendidikan di Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) Misi, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. Pendidikan tinggi bidang keperawatan dilanjutkan di Akademi Keperawatan DepKes Pajajaran Bandung dan lulus pada tahun 1990.

Penulis kemudian meraih gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro (FKM-UNDIP) Semarang pada tahun 1996. Selanjutnya, penulis menyelesaikan pendidikan Magister Keperawatan dengan peminatan Kepemimpinan dan Manajemen Pelayanan Keperawatan di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia (FIK UI) pada tahun 2008. Gelar Doktor Ilmu Keperawatan (Kepemimpinan dan Manajemen Pelayanan Keperawatan) dari FIK UI berhasil diraih pada tahun 2012.

Dalam karier profesional, penulis mengawali sebagai perawat di Rumah Sakit Misi Lebak, sebelum kemudian menekuni dunia pendidikan keperawatan. Pengalaman mengajar dimulai di SPK Misi Lebak, dilanjutkan sebagai dosen di AKPER Immanuel Bandung, dan kemudian di STIKes Immanuel Bandung. Di sana, penulis mengajar sekaligus membimbing praktik klinik untuk mahasiswa program D3 Keperawatan, S1 Keperawatan, dan Profesi Ners dari tahun 2000 hingga 2019.

Sejak tahun 2013, penulis juga dipercaya sebagai dosen tamu (dosen luar biasa) pada program Magister Keperawatan (peminatan Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan) di berbagai institusi, antara lain FIK Universitas Padjadjaran (UNPAD), STIKes Jenderal A. Yani Bandung, dan STIKes St. Carolus Jakarta. Pada tahun 2019, penulis bergabung sebagai dosen tetap di Universitas Karya Husada Semarang, dan sejak saat itu menjabat sebagai **Kepala Program Studi Magister Keperawatan** di institusi tersebut hingga sekarang. Selain itu, penulis juga menjadi dosen tamu pada program Magister Keperawatan – Prodi Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang.

Penulis aktif sebagai konsultan dalam pengembangan pendidikan keperawatan di STIKes Halmahera Utara sejak tahun 2013 hingga kini. Pengalaman internasionalnya meliputi kegiatan benchmark dan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) dengan Flinders University – Adelaide, South Australia, pada tahun 2008. Selain itu, penulis juga aktif sebagai pembicara dalam berbagai seminar nasional dan pelatihan di bidang kepemimpinan serta manajemen keperawatan di berbagai institusi pendidikan dan rumah sakit.

Pengalaman internasional lainnya termasuk benchmark dan penandatanganan MoA dengan Trinity University of Asia dan St. Luke's Hospital di Quezon City – Manila, University of the Cordilleras – Baguio City, dan University of Baguio, Filipina. Penulis juga pernah memberikan kuliah tamu di Benguet State University dan University of the Cordilleras, serta menjadi juri (judge) dalam Seminar Internasional PNA (*Philippine Nurses Association*) di Baguio City, Filipina.

DAFTAR PUSTAKA



Dr. Ns. Tri Ismu Pujiyanto, SKM, S.Kep, M.Kes, M.Kep., merupakan seorang akademisi dan praktisi di bidang kesehatan masyarakat dan keperawatan dengan pengalaman lebih dari tiga dekade di dunia pendidikan tinggi kesehatan. Lahir di Batang pada tanggal 30 Mei 1969, beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Kesehatan Masyarakat di Universitas

Diponegoro pada tahun 1996. Kemudian, beliau melanjutkan pendidikan Magister Epidemiologi di universitas yang sama dan lulus pada tahun 2004. Komitmennya dalam pengembangan ilmu keperawatan membawanya untuk meraih gelar Magister Keperawatan dari Universitas Indonesia pada tahun 2010, serta menempuh pendidikan Doktoral Ilmu Kedokteran/Kesehatan di Universitas Diponegoro yang diselesaikan pada tahun 2018. Selain itu, beliau juga menyelesaikan pendidikan Sarjana Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners di Universitas Muhammadiyah Kudus, masing-masing pada tahun 2021 dan 2022. Dalam karier profesionalnya, Dr. Tri Ismu Pujiyanto telah menjabat berbagai posisi strategis di institusi pendidikan tinggi. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur AKPER Karya Husada Semarang (1998–2003), Direktur AKKES Karya Husada Semarang (2003–2005), dan Ketua STIKES Karya Husada Semarang (2005–2014). Saat ini, beliau aktif sebagai Ketua Pembina sekaligus Pendiri Yayasan Perti Karya Husada Semarang sejak tahun 2014 dan menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Non Akademik Universitas Karya Husada Semarang sejak tahun 2022. Beliau juga merupakan dosen tetap di Karya Husada Semarang selama lebih dari 31 tahun dengan jabatan fungsional akademik sebagai Lektor Kepala

SINOPSIS BUKU

Buku monograf ini mengulas tentang pentingnya pelaksanaan evaluasi berkala terhadap kinerja perawat sebagai upaya strategis dalam peningkatan mutu pelayanan keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Evaluasi berkala tidak lagi dapat dipandang sekadar rutinitas administratif, melainkan sebagai bagian integral dari sistem manajemen mutu rumah sakit untuk menjawab tuntutan profesionalisme dan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan.

Penulis memaparkan bagaimana proses evaluasi yang terstruktur baik evaluasi orientasi, penempatan, bulanan, maupun tahunan dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kompetensi perawat, motivasi kerja, dan konsistensi dalam penerapan standar pelayanan. Buku ini juga menyoroti keterkaitan antara peningkatan kinerja perawat dengan dimensi mutu pelayanan seperti empati, kecepatan tanggap, ketepatan prosedur, dan komunikasi efektif yang dirasakan langsung oleh pasien. Melalui tinjauan teori, pengalaman praktik, dan hasil penelitian yang disajikan, pembaca diajak untuk memahami bahwa evaluasi kinerja yang adil, objektif, dan partisipatif dapat menciptakan budaya kerja yang transparan dan akuntabel. Buku ini merekomendasikan integrasi evaluasi berkala dalam kebijakan rumah sakit sebagai bagian dari siklus peningkatan mutu berkelanjutan.

Buku ini ditulis oleh seorang perawat dengan pengalaman lapangan yang luas dan keterlibatan aktif dalam pengembangan profesi, buku ini menjadi referensi berharga bagi tenaga keperawatan, manajer keperawatan, akademisi, serta pihak pengelola rumah sakit yang ingin membangun sistem evaluasi kinerja yang efektif dan berdampak nyata terhadap pelayanan pasien.

Buku monograf ini mengulas tentang pentingnya pelaksanaan evaluasi berkala terhadap kinerja perawat sebagai upaya strategis dalam peningkatan mutu pelayanan keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Evaluasi berkala tidak lagi dapat dipandang sekadar rutinitas administratif, melainkan sebagai bagian integral dari sistem manajemen mutu rumah sakit untuk menjawab tuntutan profesionalisme dan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan. Penulis memaparkan bagaimana proses evaluasi yang terstruktur baik evaluasi orientasi, penempatan, bulanan, maupun tahunan dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kompetensi perawat, motivasi kerja, dan konsistensi dalam penerapan standar pelayanan. Buku ini juga menyoroti keterkaitan antara peningkatan kinerja perawat dengan dimensi mutu pelayanan seperti empati, kecepatan tanggap, ketepatan prosedur, dan komunikasi efektif yang dirasakan langsung oleh pasien. Melalui tinjauan teori, pengalaman praktik, dan hasil penelitian yang disajikan, pembaca diajak untuk memahami bahwa evaluasi kinerja yang adil, objektif, dan partisipatif dapat menciptakan budaya kerja yang transparan dan akuntabel. Buku ini merekomendasikan integrasi evaluasi berkala dalam kebijakan rumah sakit sebagai bagian dari siklus peningkatan mutu berkelanjutan. Buku ini ditulis oleh seorang perawat dengan pengalaman lapangan yang luas dan keterlibatan aktif dalam pengembangan profesi, buku ini menjadi referensi berharga bagi tenaga keperawatan, manajer keperawatan, akademisi, serta pihak pengelola rumah sakit yang ingin membangun sistem evaluasi kinerja yang efektif dan berdampak nyata terhadap pelayanan pasien.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta

